

Formation
AMaVi aux urgences

Se préparer, se coordonner et agir efficacement
en situation sanitaire exceptionnelle

Date JJ/MM/AAAA

Prénom NOM (formateur)

VITAE
FORMATION SANTÉ

Sommaire

1. Définition
2. Législation
3. Organisation face à une situations sanitaires exceptionnelle (SSE)
4. Positionnement et organisation institutionnelle
5. Les rôles et missions des différents professionnels
6. Procédures spécifiques à un AMaVi
7. Mise en pratique : Simulation
8. Debriefing

VITAE
FORMATION SANTÉ

Définition

L'État dispose de nombreux plans, élaborés à l'échelle locale et nationale, en prévision d'accidents de grande ampleur et de catastrophes, afin d'améliorer la qualité de sa réponse et de ses actions.

Les plans visent notamment à :

- optimiser la mobilisation des ressources nécessaires pour faire face aux situations ;
- faciliter et guider la prise de décision des autorités publiques ;
- proposer des mesures et des plans d'action.

ORSEC (**Organisation de la Réponse de Sécurité Civile**)

- Dispositif **général** de gestion de crise piloté par le préfet.
- Concerne **toutes les catastrophes** : naturelles (inondations, tempêtes), technologiques, sanitaires, etc.
- Coordonne **tous les acteurs** : secours (pompiers), forces de l'ordre, santé, collectivités.

Objectif : **organiser les secours à grande échelle**.
→ C'est le cadre global dans lequel s'intègrent les autres plans.

ORSAN (**Organisation de la Réponse du Système de Santé en situations Sanitaires exceptionnelles**)

- Déclinaison sanitaire du plan ORSEC.
- Organise la réponse du **système de santé** (hôpitaux, SAMU, ARS).
- Prévoit différents volets selon la situation :
  - ORSAN AMAVI (attentats)
  - ORSAN REB (épidémie)
  - ORSAN CLIM (canicule/froid)
  - ORSAN NRC (nucléaire, radiologique, chimique)
  - ORSAN MEDICO-PSY (nombreuses victimes, blessés psychiques)
  - ORSAN CYBER (fonctionnement des systèmes d'information)

Objectif : **adapter rapidement l'offre de soins à une situation exceptionnelle**.

VITAE
FORMATION SANTÉ

Définition

L'État dispose de nombreux plans, élaborés à l'échelle locale et nationale, en prévision d'accidents de grande ampleur et de catastrophes, afin d'améliorer la qualité de sa réponse et de ses actions.

Les plans visent notamment à :

- optimiser la mobilisation des ressources nécessaires pour faire face aux situations ;
- faciliter et guider la prise de décision des autorités publiques ;
- proposer des mesures et des plans d'action.

AMaVi (Afflux Massif de Victimes)

Situation où le nombre de victimes dépasse les capacités habituelles.
Peut être lié à :

- attentat
- accident collectif (car, train…)
- catastrophe

Ce n'est pas un plan en soi, mais une **situation opérationnelle** qui déclenche des dispositifs comme ORSEC/ORSAN.

Plan Blanc

Plan interne aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques).
Déclenché par le directeur de l'établissement.
Permet de :

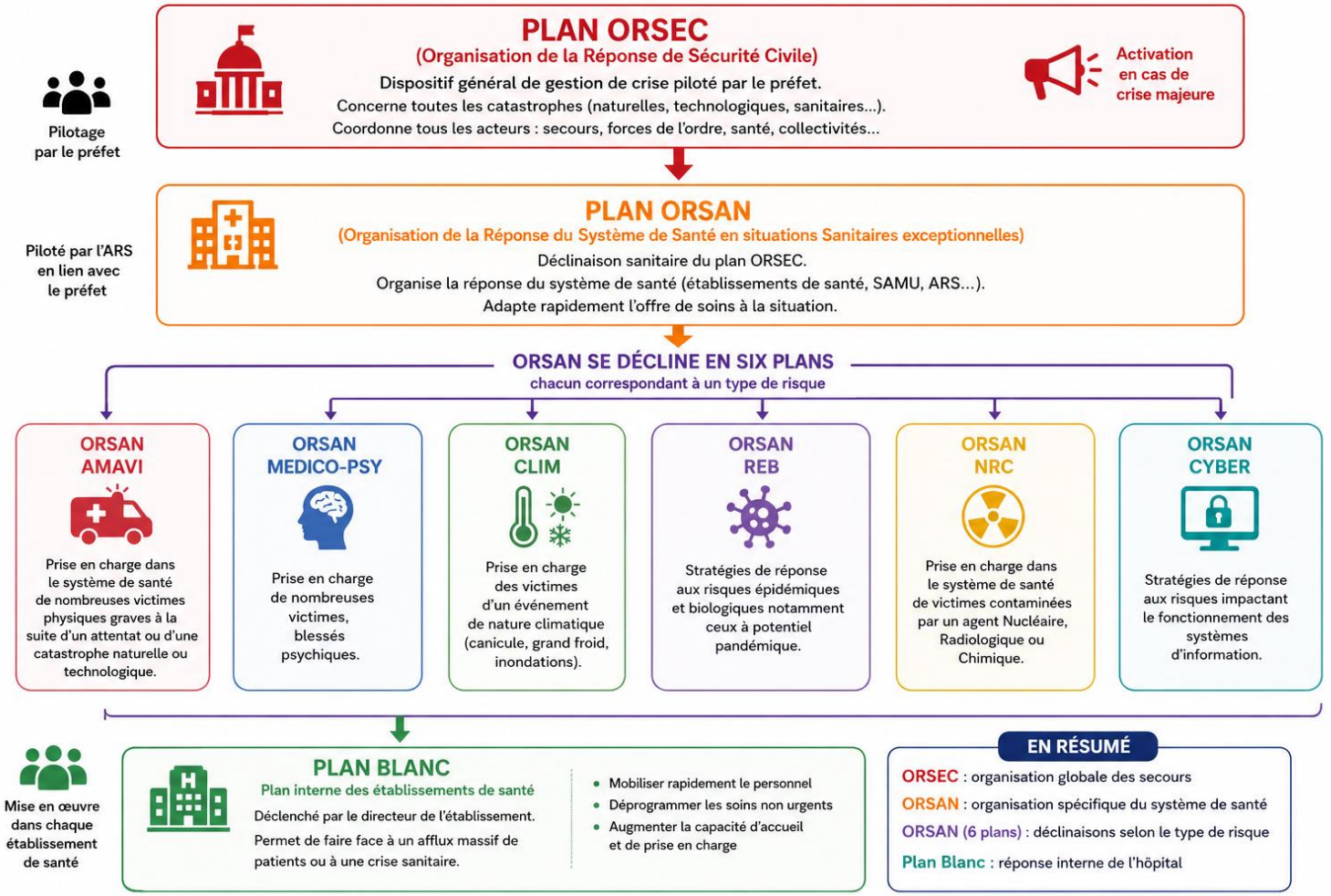
- mobiliser rapidement le personnel
- déprogrammer les soins non urgents
- augmenter la capacité d'accueil

Objectif : **faire face à un afflux massif de patients ou une crise sanitaire**.

VITAE
FORMATION SANTÉ

Définition

En résumé :



VITAE
FORMATION SANTÉ

Législation

Cadre légal global : sécurité civile (ORSEC)

Texte fondateur

Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile → crée le dispositif ORSEC

Textes d'application

Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005

Codifié dans le Code de la sécurité intérieure (articles L741-1 et suivants / R741-1…)

Ce que dit la loi :

ORSEC organise : la mobilisation et coordination de tous les acteurs (publics et privés)

Le préfet est autorité de direction des secours

Le plan doit :

- analyser les risques
- prévoir les moyens
- organiser la réponse opérationnelle

C'est le socle juridique global de la gestion de crise.

VITAE
FORMATION SANTÉ

Législation

Cadre légal sanitaire : ORSAN

Texte principal

Article L3131-11 du Code de la santé publique

Décrets d'application

Articles R3131-4 à R3131-5 CSP

Ce que dit la loi :

ORSAN organise la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle

Il précise :

- les modalités de déclenchement
- l'organisation régionale (ARS)
- les établissements de référence

Il doit s'articuler avec ORSEC

C'est le cadre juridique de la gestion sanitaire de crise.

VITAE
FORMATION SANTÉ

Législation

Cadre réglementaire du Plan Blanc

Base légale

Code de la santé publique :

Articles L3131-7, R3131-4, R3131-5

Obligations légales :

Tous les établissements de santé doivent : avoir un Plan Blanc obligatoire

Le plan prévoit :

- mobilisation du personnel
- organisation de crise interne
- gestion d'un afflux massif de patients

Il donne une base juridique pour réquisitionner du personnel et adapter l'activité.

VITAE
FORMATION SANTÉ

Législation

AMaVi : pas un texte, mais un concept opérationnel

❗ AMaVi n'est pas défini par une loi spécifique

C'est une situation reconnue dans les dispositifs ORSEC/ORSAN

Intégré dans :

- ORSEC (ex : ORSEC NOVI)
- ORSAN AMAVI

Donc : statut = notion opérationnelle, pas juridique autonome

Circulaires et instructions (niveau pratique)

Plusieurs textes complètent la loi :

- Instruction interministérielle du 2 janvier 2019 (ORSAN)
- Circulaires ARS (organisation régionale)
- Guides méthodologiques (mise en œuvre terrain)

Ils précisent :

- les 6 volets ORSAN (AMAVI, REB, CLIM, etc.)
- l'organisation concrète des acteurs

VITAE
FORMATION SANTÉ

Organisation face à une situation sanitaire exceptionnelle (SSE)

Une **Situation Sanitaire Exceptionnelle (SSE)** est un événement :

- inhabituel
- grave
- dépassant les capacités habituelles du système de santé



Exemples de SSE :

- Attentats
- Catastrophes naturelles (inondations, canicule)
- Épidémies (COVID-19)
- Accidents collectifs







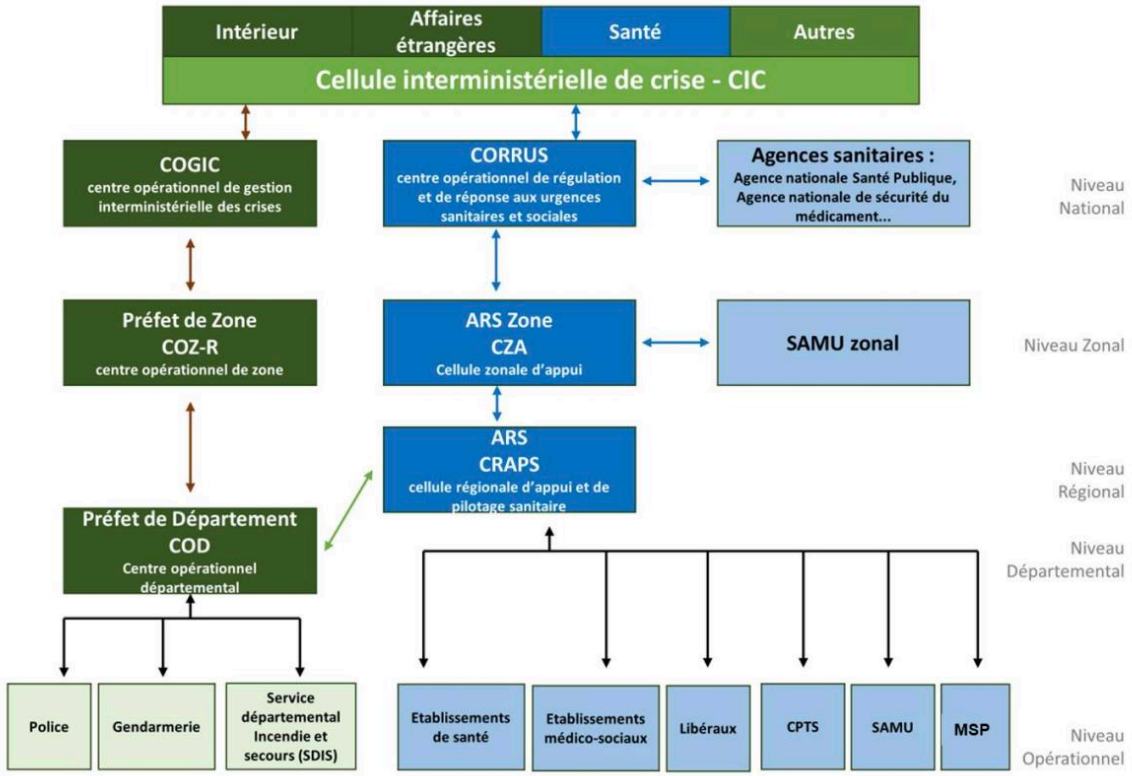
Objectifs

- Adapter rapidement le système de santé
- Assurer une prise en charge optimale des victimes
- Coordonner les acteurs (SAMU, hôpitaux, ARS…)

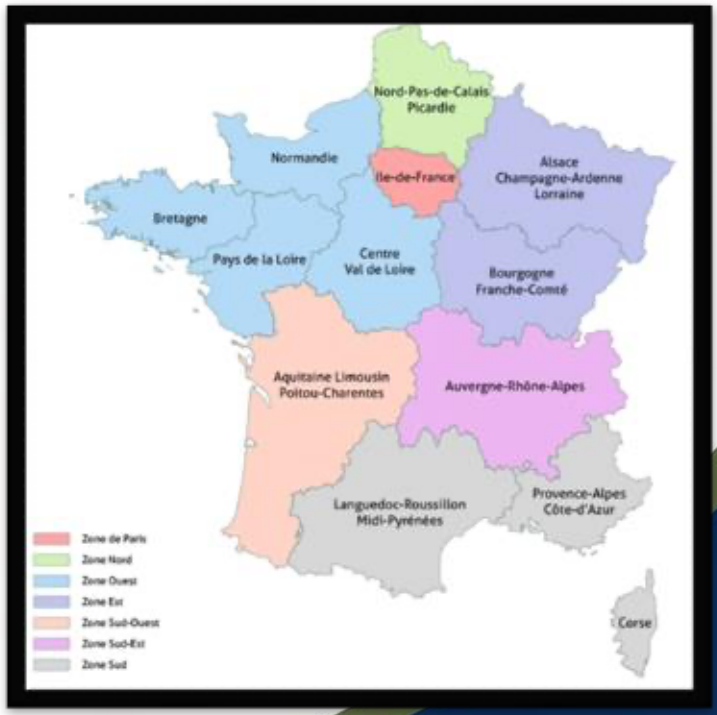
VITAE
FORMATION SANTÉ

Organisation face à une situation sanitaire exceptionnelle (SSE)

Différents échelons d'intervention en situation de crise



Zone de défense en France



VITAE
FORMATION SANTÉ

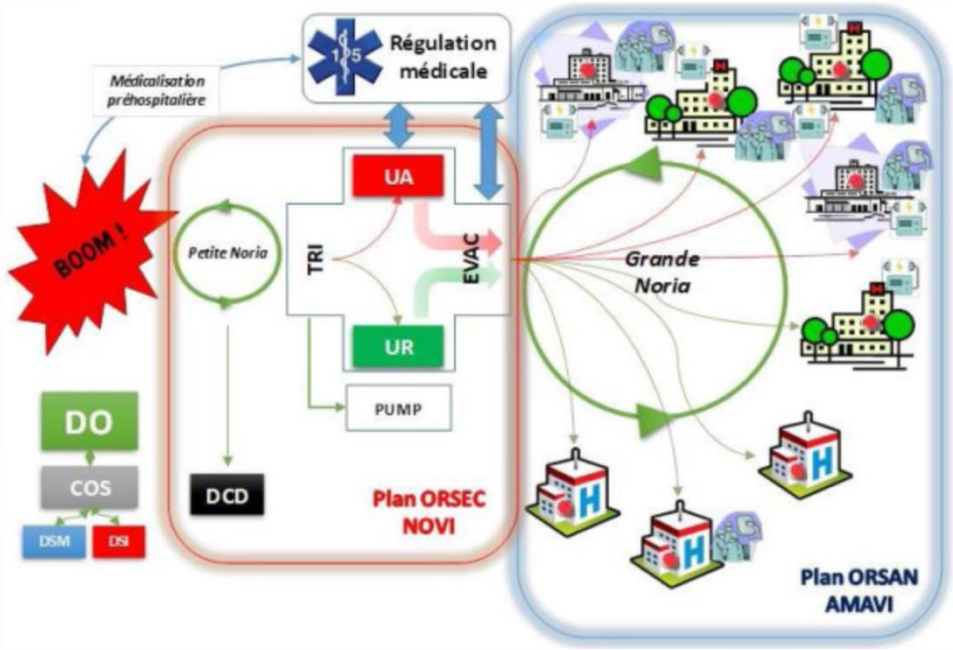
Organisation face à une situation sanitaire exceptionnelle (SSE)

Plan ORSEC

- Organisation globale des secours
- Piloté par le **préfet**
- Coordonne tous les acteurs (secours, santé, forces de l'ordre)

Plan ORSAN

- Déclinaison sanitaire du plan ORSEC
- Piloté par l'**ARS**
- Organise la réponse du système de santé



https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1279847923000034

VITAE FORMATION SANTÉ

Organisation face à une situation sanitaire exceptionnelle (SSE)

ORSAN se décline en 6 volets :

AMaVi

prise en charge dans le système de santé de nombreuses victimes physiques graves

Médico-Psy

prise en charge de nombreuses victimes, blessés psychiques

EPI-CLIM

prise en charge des victimes d'un événement de nature climatique (canicule, grand froid, inondations)

REB

stratégies de réponse aux risques épidémiques et biologiques notamment ceux à potentiel pandémique

NRC

prise en charge dans le système de santé de victimes contaminées par un agent Nucléaire, Radiologique ou Chimique

+

NEW

Cyber

stratégies de réponse aux risques impactant le fonctionnement des systèmes d'information

VITAE FORMATION SANTÉ

Organisation face à une situation sanitaire exceptionnelle (SSE)



Plan Blanc

- Plan interne de gestion de crise
- Déclenché par le directeur

Actions :

- Mobilisation du personnel
- Déprogrammation des soins
- Augmentation des capacités d'accueil

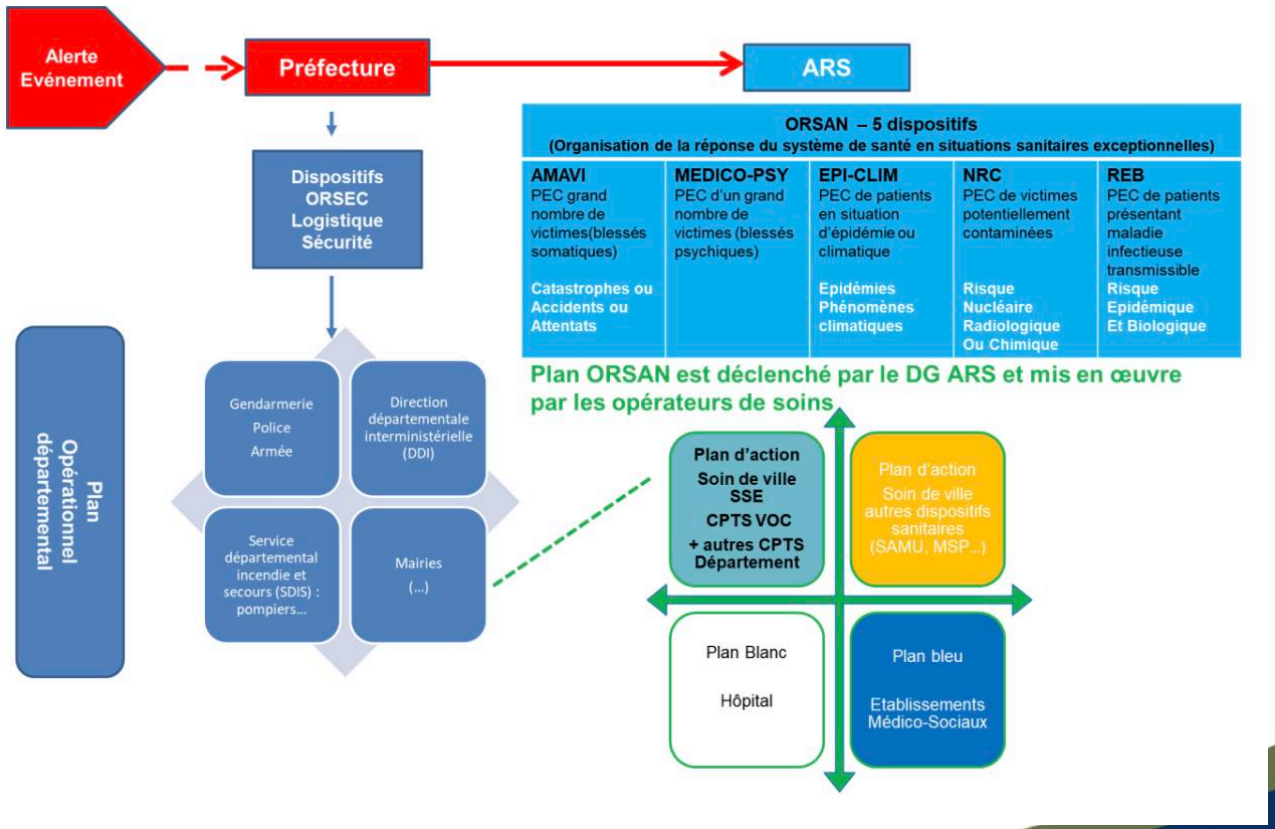
Autres dispositifs :

- Plan Blanc élargi (coordination territoriale)
- Cellule de crise hospitalière

VITAE
FORMATION SANTÉ

Positionnement et organisation institutionnelle

Schéma d'organisation de la crise au niveau territorial



VITAE FORMATION SANTÉ

Positionnement et organisation institutionnelle

Déclenchement d'un volet AMaVI aux urgences

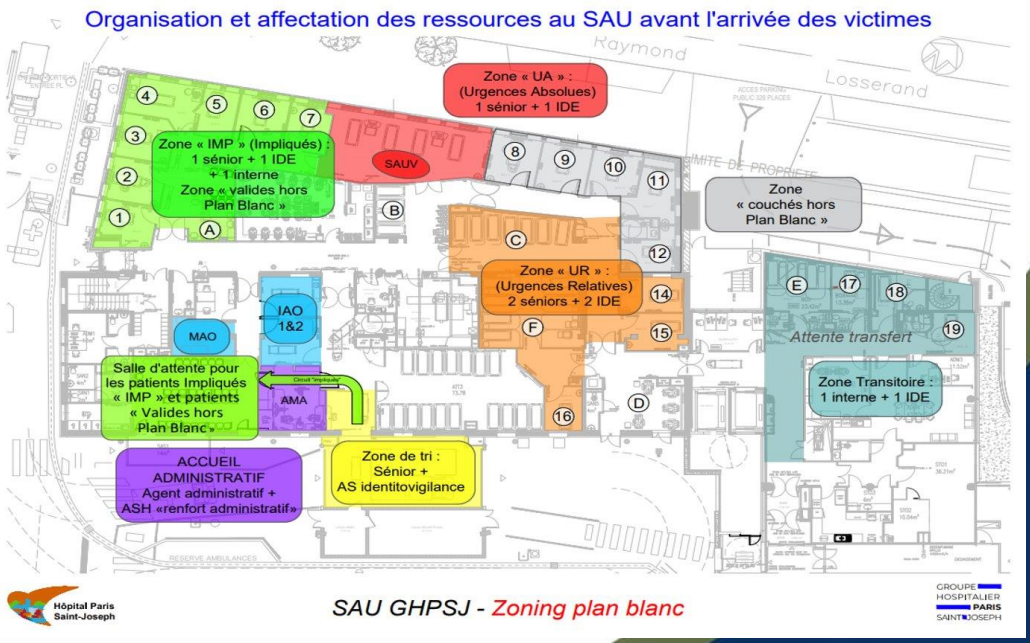
- Arrivée de plusieurs personnes, présentant des signes cliniques évocateurs (plaies, même discours, même lieu, environnement,...) → Déclenchement fait par un soignant (agent d'accueil, IDE, AS, ...).
- Appel du SAMU dans le service
- Appel des ARS

VITAE FORMATION SANTÉ

Positionnement et organisation institutionnelle

Organisation du service des urgences

- Fermeture des entrées : 1 entrée unique (celle du SAS pompier)
- Regroupement des différentes professionnelles dans le poste de soin et répartition des rôles
- Désignation d'un médecin responsable AMaVi et d'un IDE responsable AMaVi
- Organisation du service en différentes zones (4 zones)
- Répartition des effectifs dans chaque zone
- Evacuation des urgences, transfert des patients dans la zone transitoire avant d'être transférés dans les services de l'hôpital.
- Accueil des premières victimes.



VITAE
FORMATION SANTÉ

Positionnement et organisation institutionnelle

Organisation de l'hôpital :

Réanimation :

- Sortie de 2 patients vers USIC/USINV
- Réanimateur en SSPI.

SSPI / Bloc opératoire :

- Arrêt de certains blocs
- Sortie/Transfert patients SSPI vers USIC/USINV
- Accueil victime UA du SAU

USIC / USINV :

- Transfert des patients vers la cardiologie salle et la neurologie salle

Service de soins :

- Se prépare à accueillir au minimum 2 patients des urgences.

VITAE
FORMATION SANTÉ

Positionnement et organisation institutionnelle

Cellule de crise

Composition

- Directeur de l'hôpital
- Attachée de direction
- Administrateur de garde
- Cadre de garde/nuit
- Urgences
- Bloc opératoire
- Directrice de soins
- Président de la Commission Médicale d'Etablissement
- Qualité - gestion des risques

Vision panoramique du préhospitalier, du terrain, des autres hôpitaux.
→ En lien avec l'ARS

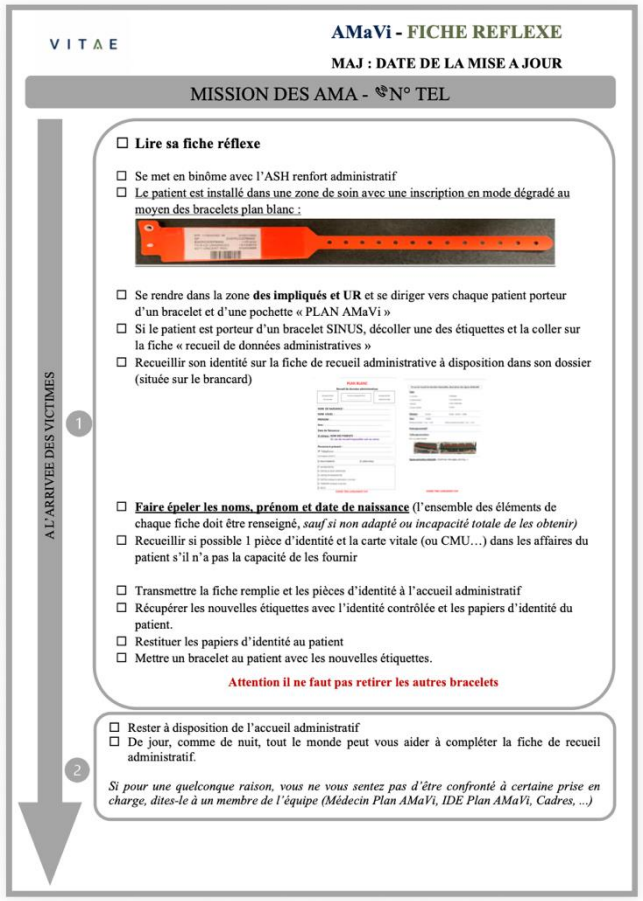
Rôle

- Organisation de la prise en charge médicale
  - Etats des lits
  - Rappel de personnel
  - Déprogrammation de patients convoqués…
- Assure-la sûreté, la sécurité
- Le suivi des victimes
- La prise en charge des familles
- Les fonctions support et la communication

VITAE FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Agent médical et administrative (AMA)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DES AMA - N° TEL

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Se met en binôme avec l'ASH renfort administratif
- ☐ Le patient est installé dans une zone de soin avec une inscription en mode dégradé au moyen des bracelets plan blanc :
- ☐ Se rendre dans la zone **des impliqués et UR** et se diriger vers chaque patient porteur d'un bracelet et d'une pochette « PLAN AMaVi »
- ☐ Si le patient est porteur d'un bracelet SINUS, décoller une des étiquettes et la coller sur la fiche « recueil de données administratives »
- ☐ Recueillir son identité sur la fiche de recueil administrative à disposition dans son dossier (située sur le brancard)
- ☐ **Faire épeler les noms, prénom et date de naissance** (l'ensemble des éléments de chaque fiche doit être renseigné, *sauf si non adapté ou incapacité totale de les obtenir)*
- ☐ Recueillir si possible 1 pièce d'identité et la carte vitale (ou CMU…) dans les affaires du patient s'il n'a pas la capacité de les fournir
- ☐ Transmettre la fiche remplie et les pièces d'identité à l'accueil administratif
- ☐ Récupérer les nouvelles étiquettes avec l'identité contrôlée et les papiers d'identité du patient.
- ☐ Restituer les papiers d'identité au patient
- ☐ Mettre un bracelet au patient avec les nouvelles étiquettes.

Attention il ne faut pas retirer les autres bracelets

2

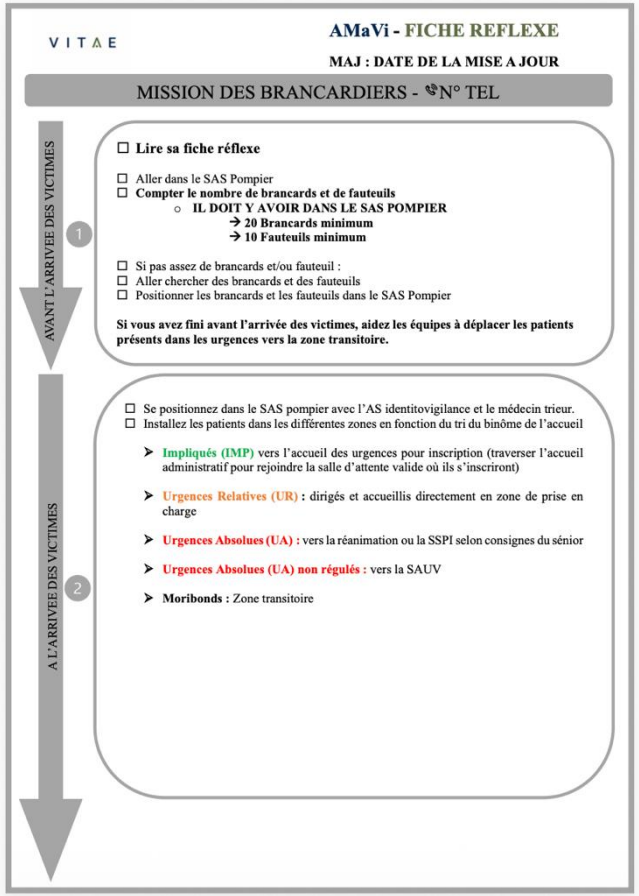
- ☐ Rester à disposition de l'accueil administratif
- ☐ De jour, comme de nuit, tout le monde peut vous aider à compléter la fiche de recueil administratif.

Si pour une quelconque raison, vous ne vous sentez pas d'être confronté à certaine prise en charge, dites-le à un membre de l'équipe (Médecin Plan AMaVi, IDE Plan AMaVi, Cadres, ...)

VITAE FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Brancardier



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DES BRANCARDIERS - N° TEL

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Aller dans le SAS Pompier
- ☐ **Compter le nombre de brancards et de fauteuils**
  - **IL DOIT Y AVOIR DANS LE SAS POMPIER**
    - → **20 Brancards minimum**
    - → **10 Fauteuils minimum**
- ☐ Si pas assez de brancards et/ou fauteuil :
- ☐ Aller chercher des brancards et des fauteuils
- ☐ Positionner les brancards et les fauteuils dans le SAS Pompier

Si vous avez fini avant l'arrivée des victimes, aidez les équipes à déplacer les patients présents dans les urgences vers la zone transitoire.

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2

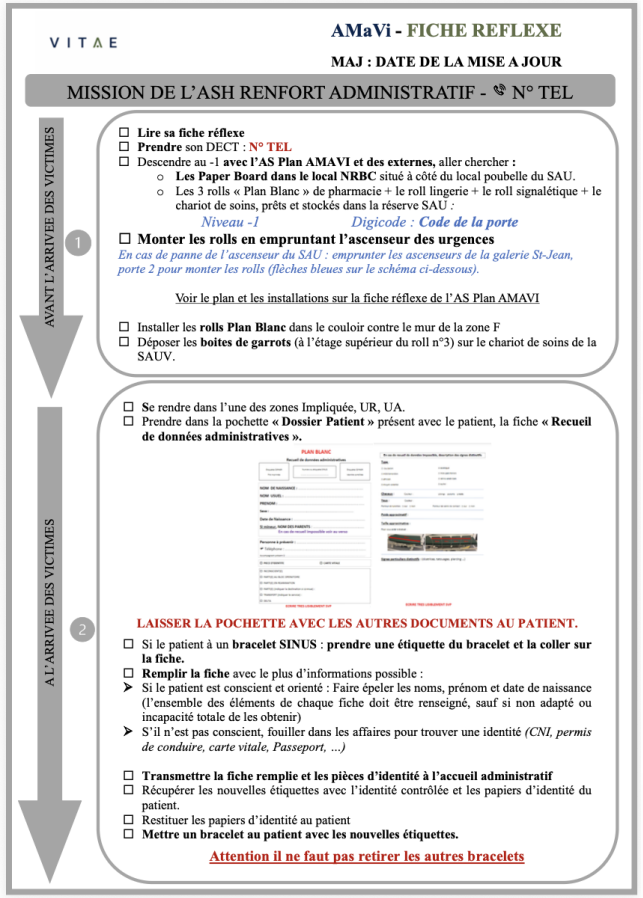
- ☐ Se positionnez dans le SAS pompier avec l'AS identitovigilance et le médecin trieur.
- ☐ Installez les patients dans les différentes zones en fonction du tri du binôme de l'accueil

- ➢ **Impliqués (IMP)** vers l'accueil des urgences pour inscription (traverser l'accueil administratif pour rejoindre la salle d'attente valide où ils s'inscriront)
- ➢ **Urgences Relatives (UR) :** dirigés et accueillis directement en zone de prise en charge
- ➢ **Urgences Absolues (UA) :** vers la réanimation ou la SSPI selon consignes du sénior
- ➢ **Urgences Absolues (UA) non régulés :** vers la SAUV
- ➢ **Moribonds :** Zone transitoire

VITAE FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Agent de service hospitalier (ASH)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'ASH RENFORT ADMINISTRATIF - ✆ N° TEL

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ **Prendre** son DECT : **N° TEL**
- ☐ Descendre au -1 **avec l'AS Plan AMAVI et des externes,** aller chercher :
  - **Les Paper Board dans le local NRBC** situé à côté du local poubelle du SAU.
  - Les 3 rolls « Plan Blanc » de pharmacie + le roll lingerie + le roll signalétique + le chariot de soins, prêts et stockés dans la réserve SAU :

Niveau -1 *Digicode : **Code de la porte***

- ☐ **Monter les rolls en empruntant l'ascenseur des urgences**

En cas de panne de l'ascenseur du SAU : emprunter les ascenseurs de la galerie St-Jean, porte 2 pour monter les rolls (flèches bleues sur le schéma ci-dessous).

Voir le plan et les installations sur la fiche réflexe de l'AS Plan AMAVI

- ☐ Installer les **rolls Plan Blanc** dans le couloir contre le mur de la zone F
- ☐ Déposer les **boites de garrots** (à l'étage supérieur du roll n°3) sur le chariot de soins de la SAUV.

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

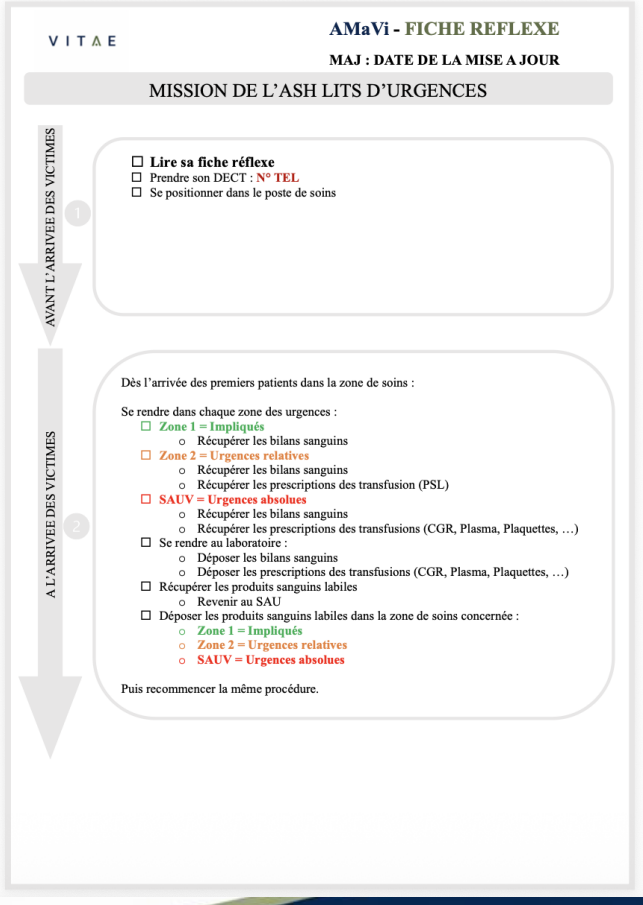
2

- ☐ Se rendre dans l'une des zones Impliquée, UR, UA.
- ☐ Prendre dans la pochette **« Dossier Patient »** présent avec le patient, la fiche **« Recueil de données administratives ».**

LAISSER LA POCHETTE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS AU PATIENT.

- ☐ Si le patient à un **bracelet SINUS** : **prendre une étiquette du bracelet et la coller sur la fiche.**
- ☐ **Remplir la fiche** avec le plus d'informations possible :
  - ➢ Si le patient est conscient et orienté : Faire épeler les noms, prénom et date de naissance (l'ensemble des éléments de chaque fiche doit être renseigné, sauf si non adapté ou incapacité totale de les obtenir)
  - ➢ S'il n'est pas conscient, fouiller dans les affaires pour trouver une identité *(CNI, permis de conduire, carte vitale, Passeport, …)*
- ☐ **Transmettre la fiche remplie et les pièces d'identité à l'accueil administratif**
- ☐ Récupérer les nouvelles étiquettes avec l'identité contrôlée et les papiers d'identité du patient.
- ☐ Restituer les papiers d'identité au patient
- ☐ **Mettre un bracelet au patient avec les nouvelles étiquettes.**

Attention il ne faut pas retirer les autres bracelets



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'ASH LITS D'URGENCES

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**
- ☐ Se positionner dans le poste de soins

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2

Dès l'arrivée des premiers patients dans la zone de soins :

Se rendre dans chaque zone des urgences :

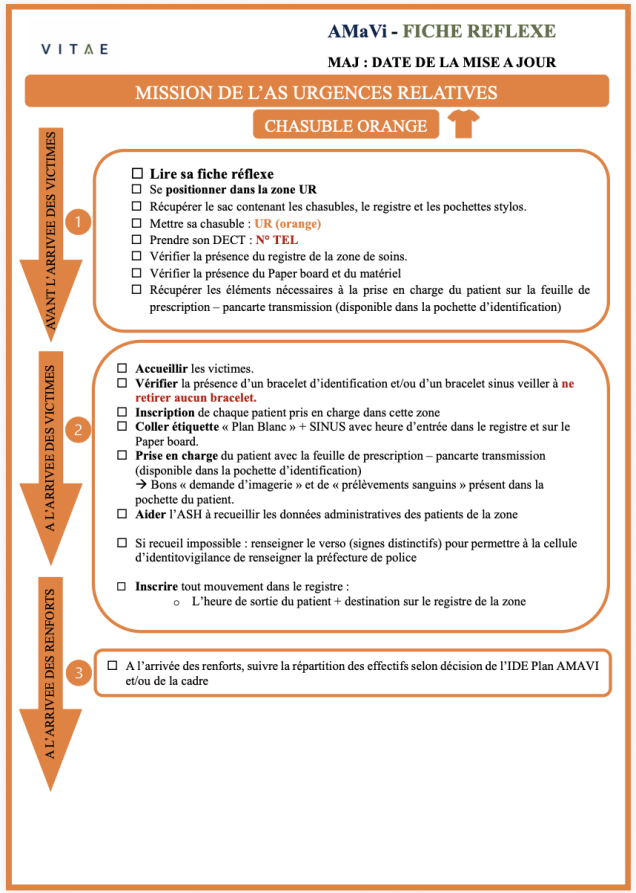
- ☐ **Zone 1 = Impliqués**
  - Récupérer les bilans sanguins
- ☐ **Zone 2 = Urgences relatives**
  - Récupérer les bilans sanguins
  - Récupérer les prescriptions des transfusion (PSL)
- ☐ **SAUV = Urgences absolues**
  - Récupérer les bilans sanguins
  - Récupérer les prescriptions des transfusions (CGR, Plasma, Plaquettes, …)
- ☐ Se rendre au laboratoire :
  - Déposer les bilans sanguins
  - Déposer les prescriptions des transfusions (CGR, Plasma, Plaquettes, …)
- ☐ Récupérer les produits sanguins labiles
  - Revenir au SAU
- ☐ Déposer les produits sanguins labiles dans la zone de soins concernée :
  - **Zone 1 = Impliqués**
  - **Zone 2 = Urgences relatives**
  - **SAUV = Urgences absolues**

Puis recommencer la même procédure.

VITAE FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Aide-soignant (AS)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'AS URGENCES RELATIVES

CHASUBLE ORANGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

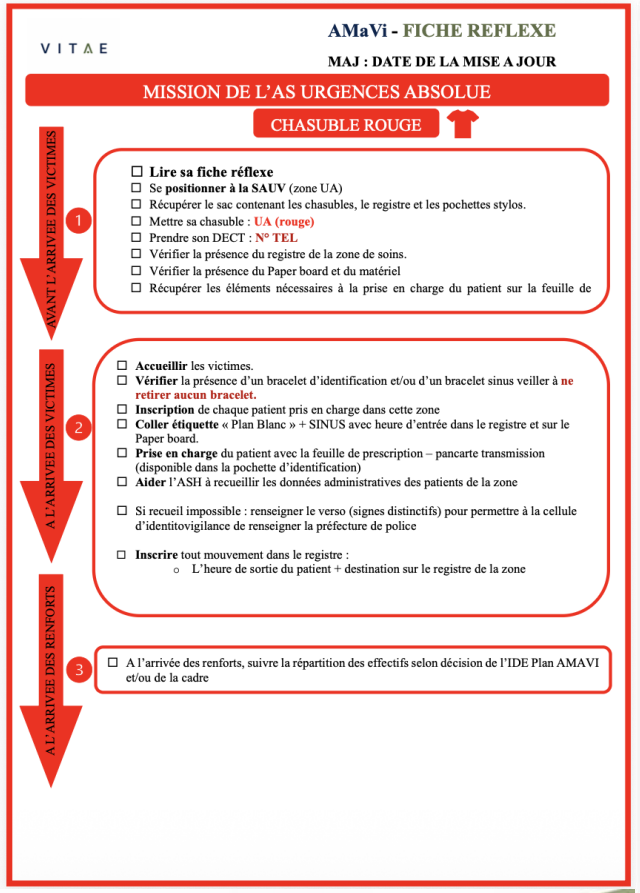
1
- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Se **positionner dans la zone UR**
- ☐ Récupérer le sac contenant les chasubles, le registre et les pochettes stylos.
- ☐ Mettre sa chasuble : **UR (orange)**
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**
- ☐ Vérifier la présence du registre de la zone de soins.
- ☐ Vérifier la présence du Paper board et du matériel
- ☐ Récupérer les éléments nécessaires à la prise en charge du patient sur la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2
- ☐ **Accueillir** les victimes.
- ☐ **Vérifier** la présence d'un bracelet d'identification et/ou d'un bracelet sinus veiller à **ne retirer aucun bracelet.**
- ☐ **Inscription** de chaque patient pris en charge dans cette zone
- ☐ **Coller étiquette** « Plan Blanc » + SINUS avec heure d'entrée dans le registre et sur le Paper board.
- ☐ **Prise en charge** du patient avec la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)
  → Bons « demande d'imagerie » et de « prélèvements sanguins » présent dans la pochette du patient.
- ☐ **Aider** l'ASH à recueillir les données administratives des patients de la zone
- ☐ Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police
- ☐ **Inscrire** tout mouvement dans le registre :
  - L'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

A L'ARRIVEE DES RENFORTS

3
- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision de l'IDE Plan AMAVI et/ou de la cadre



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'AS URGENCES ABSOLUE

CHASUBLE ROUGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

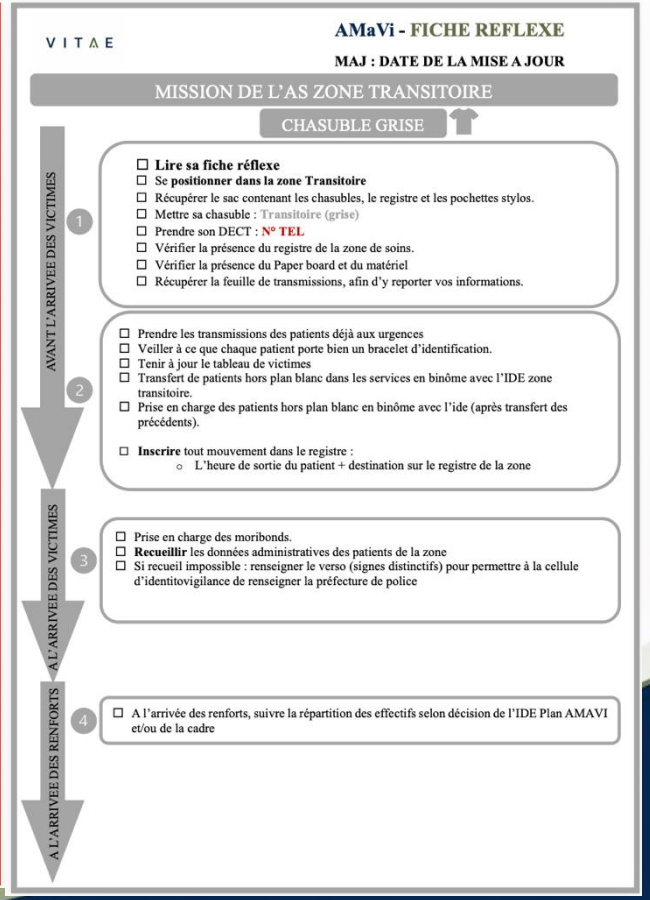
1
- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Se **positionner à la SAUV** (zone UA)
- ☐ Récupérer le sac contenant les chasubles, le registre et les pochettes stylos.
- ☐ Mettre sa chasuble : **UA (rouge)**
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**
- ☐ Vérifier la présence du registre de la zone de soins.
- ☐ Vérifier la présence du Paper board et du matériel
- ☐ Récupérer les éléments nécessaires à la prise en charge du patient sur la feuille de

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2
- ☐ **Accueillir** les victimes.
- ☐ **Vérifier** la présence d'un bracelet d'identification et/ou d'un bracelet sinus veiller à **ne retirer aucun bracelet.**
- ☐ **Inscription** de chaque patient pris en charge dans cette zone
- ☐ **Coller étiquette** « Plan Blanc » + SINUS avec heure d'entrée dans le registre et sur le Paper board.
- ☐ **Prise en charge** du patient avec la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)
- ☐ **Aider** l'ASH à recueillir les données administratives des patients de la zone
- ☐ Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police
- ☐ **Inscrire** tout mouvement dans le registre :
  - L'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

A L'ARRIVEE DES RENFORTS

3
- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision de l'IDE Plan AMAVI et/ou de la cadre



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'AS ZONE TRANSITOIRE

CHASUBLE GRISE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Se **positionner dans la zone Transitoire**
- ☐ Récupérer le sac contenant les chasubles, le registre et les pochettes stylos.
- ☐ Mettre sa chasuble : **Transitoire (grise)**
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**
- ☐ Vérifier la présence du registre de la zone de soins.
- ☐ Vérifier la présence du Paper board et du matériel
- ☐ Récupérer la feuille de transmissions, afin d'y reporter vos informations.

2
- ☐ Prendre les transmissions des patients déjà aux urgences
- ☐ Veiller à ce que chaque patient porte bien un bracelet d'identification.
- ☐ Tenir à jour le tableau de victimes
- ☐ Transfert de patients hors plan blanc dans les services en binôme avec l'IDE zone transitoire.
- ☐ Prise en charge des patients hors plan blanc en binôme avec l'ide (après transfert des précédents).
- ☐ **Inscrire** tout mouvement dans le registre :
  - L'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

3
- ☐ Prise en charge des moribonds.
- ☐ **Recueillir** les données administratives des patients de la zone
- ☐ Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police

A L'ARRIVEE DES RENFORTS

4
- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision de l'IDE Plan AMAVI et/ou de la cadre

VITAE FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Aide-soignant (AS)

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'AS DES LITS D'URGENCES - ☎81.45

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

☐ Lire sa fiche réflexe

De jour en semaine :

☐ Appelez la cadre de pharmacie (**69.00**) pour récupérer les bouteilles à oxygène et les vaccins antitétanique.

De nuit ou le weekend :

☐ Appelez l'interne de garde de pharmacie (**77.05**).

☐ Se rendre à la pharmacie (P16 – Niveau -1)
☐ Récupérer les 10 bouteilles à oxygène dans le local gaz à la pharmacie
☐ Récupérer les vaccins antitétaniques
☐ Rangez les bouteilles à oxygènes dans le couloir des urgences (à côté du poste de soins avec le stock habituel d'oxygène).
☐ Déposez les vaccins sur la paillasse du poste de soins.

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2

☐ Se positionnez dans le poste de soins, au tableau de géolocalisation (si besoin, prendre le tableau Velléda situé dans la cage au niveau de la réserve SAU).
☐ **Ne jamais quitter son poste**

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'AS PLAN AMAVI - ☎ N° TEL

CHASUBLE BLEU

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

☐ **Lire sa fiche réflexe**
☐ Récupérer la clé de l'ascenseur dans la mallette Plan Blanc
☐ Accompagné d'**1 ASH et des externes**, aller chercher :
- **Les Paper Board dans le local NRBC** situé à côté du local poubelle du SAU.
- Les 3 rolls « Plan Blanc » de pharmacie + le roll de solutés + le roll lingerie + le chariot de soins, prêts et stockés dans la réserve SAU :

Niveau -1 *Digicode : **Code de la porte***



Sur ordre, récupérer également le roll « **Plan Blanc Pédiatrique** »

2

☐ **Monter les rolls en empruntant l'ascenseur des urgences**
En cas de panne de l'ascenseur du SAU : emprunter les ascenseurs de la galerie St-Jean, porte 2 pour monter les rolls (flèches bleues sur le schéma ci-dessous).



3

☐ Installer les **rolls Plan Blanc** dans le couloir contre le mur de la zone F
☐ Déposer les **boites de garrots** (à l'étage supérieur du roll n°3) sur le chariot de soins de la SAUV.
☐ Installer les **paper-boards** :
- 1 en zone de tri
- 1 devant le box 1
- 1 dans la zone UR
- 1 en zone UA
- 1 en zone transitoire.



☐ Chaque paper-board est accompagné d'un sac contenant les chasubles, les pochettes stylos et le registre de la zone.

Lorsque l'installation est terminée :
☐ Se mettre à disposition du sénior à l'accueil pour accompagner les patients en zone UR, UA ou en salle d'attente impliqués

---

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSION DE L'AS IDENTITOVIGILANCE

CHASUBLE JAUNE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

☐ **Lire sa fiche réflexe**
☐ Ouvrir la mallette AS IDENTITOVIGILANCE et récupérer le carton contenant les pochettes « Dossier patient »



2

☐ Récupérer le sac contenant les chasubles, le registre et les pochettes stylos.
☐ Mettre sa chasuble : **AS Identitovigilance (jaune)**
☐ Se positionner dans le SAS pompiers
☐ Déposer les pochettes « Dossier patient » sur le bord de l'accueil côté entrée secours



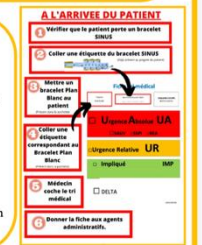
A L'ARRIVEE DES VICTIMES

3

☐ Vérifier si le patient porte un bracelet SINUS
NE JAMAIS RETIRER LE BRACELET SINUS, JUSQU'A LA SORTIE DU PATIENT



☐ Prendre une pochette « Dossier patient »
☐ Prendre une étiquette du bracelet SINUS et la coller sur la fiche Tri médical (2)
☐ Prendre le bracelet « Identité Plan Blanc » et le mettre au poignet du patient. (3)
☐ Récupérer la fiche « Tri médical » rempli par le médecin et la remettre immédiatement à l'agent d'accueil (5 et 6)
☐ Orienter les patients et guider les brancardiers selon les consignes du médecin trieur (voir zone sur le plan verso)



VITAE FORMATION SANTÉ

Les r… …es différents profe…

Infirmier (IDE)

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IDE PLAN AMAVI - N° TEL

CHASUBLE BLEU

1
- ☐ Prévenir les agents administratifs de l'accueil **N° TEL** et l'agent de sûreté **N° TEL**
  → Si pas de réponse téléphonique, se déplacer pour les prévenir oralement.
- ☐ Composer le **N° TEL** et demander l'affectation immédiate de **2** brancardiers aux urgences.
  → *Remettre la fiche réflexe aux brancardiers à leur arrivée dans le service*

- ☐ Ouvrir la mallette **« Plan Blanc »** + Mallette **« Chasubles »**
- ☐ Afficher le plan des urgences
- ☐ Désigner les rôles et donner les fiches réflexes comme suit :
  1 – Désigner **1 AS « Plan Blanc »** ET **1 Externe**
  2 – Désigner **2 ASH « renfort-administratif »**



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IDE URGENCES RELATIVE

CHASUBLE ORANGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Se **positionner dans la zone UR**
- ☐ Mettre sa chasuble : **UR (orange)**
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**
- ☐ Vérifier la présence du registre de la zone de soins.
- ☐ Vérifier la présence du Paper board et du matériel
- ☐ Récupérer les éléments nécessaires à la prise en charge du patient sur la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2
- ☐ **Accueillir** les victimes.
- ☐ **Vérifier** la présence d'un bracelet d'identification et/ou d'un bracelet sinus veiller à **ne retirer aucun bracelet.**
- ☐ **Inscription** de chaque patient pris en charge dans cette zone
- ☐ **Coller étiquette** « Plan Blanc » + SINUS avec heure d'entrée dans le registre et sur le Paper board.
- ☐ **Prise en charge** du patient avec la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)
  → Bons « demande d'imagerie » et de « prélèvements sanguins » présent dans la pochette du patient.
- ☐ **Aider** l'ASH à recueillir les données administratives des patients de la zone

- ☐ Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police

- ☐ **Inscrire** tout mouvement dans le registre :
  - L'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

A L'ARRIVEE DES RENFORTS

3
- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision de l'IDE Plan AMAVI et/ou de la cadre

---

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IDE URGENCES ABSOLUE

CHASUBLE ROUGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Se **positionner à la SAUV**
- ☐ Mettre sa chasuble : **UA (rouge)**
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**
- ☐ Vérifier la présence du registre de la zone de soins.
- ☐ Vérifier la présence du Paper board et du matériel
- ☐ Récupérer les éléments nécessaires à la prise en charge du patient sur la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2
- ☐ **Accueillir** les victimes.
- ☐ **Vérifier** la présence d'un bracelet d'identification et/ou d'un bracelet sinus veiller à **ne retirer aucun bracelet.**
- ☐ **Inscription** de chaque patient pris en charge dans cette zone
- ☐ **Coller étiquette** « Plan Blanc » + SINUS avec heure d'entrée dans le registre et sur le Paper board.
- ☐ **Prise en charge** du patient avec la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)
  → Bons « demande d'imagerie » et de « prélèvements sanguins » présent dans la pochette du patient.
- ☐ **Aider** l'ASH à recueillir les données administratives des patients de la zone

- ☐ Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police

- ☐ **Inscrire** tout mouvement dans le registre :
  - L'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

A L'ARRIVEE DES RENFORTS

3
- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision de l'IDE Plan AMAVI et/ou de la cadre

---

VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IDE ZONE TRANSITOIRE - N° TEL

CHASUBLE GRIS

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Se positionner dans sa zone
- ☐ Mettre sa chasuble : Transitoire (gris)
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**

2
- ☐ Prendre les transmissions des patients déjà aux urgences
- ☐ Se positionner dans sa zone.
- ☐ Organiser la zone :
  Un côté pour les patients à hospitaliser
  Un côté pour les patients moribonds
- ☐ Tableau Velléda pour décompte des victimes
- ☐ Registre de décompte des patients présents
- ☐ Faire monter dans les étages les patients transmis hors plan blanc (en lien avec le gestionnaire de lits)
- ☐ Prise en charge des patients hors plan blanc (après transfert des autres)

3

ORGANISATION DU TRANSFERT DES PATIENTS VERS LES ETAGES

Envoyer les patients 2 par 2, en respectant l'ordre suivant :

1- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
2- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
3- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
4- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
5- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
6- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
7- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
8- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
9- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
10- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
11- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
12- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
13- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
14- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*
15- Service de soins (LIEU/ETAGE) – ☎ **N° TEL** – *Cadre N° TEL*

WEEKEND : CADRE N° TEL // NUIT – CADRE N° TEL

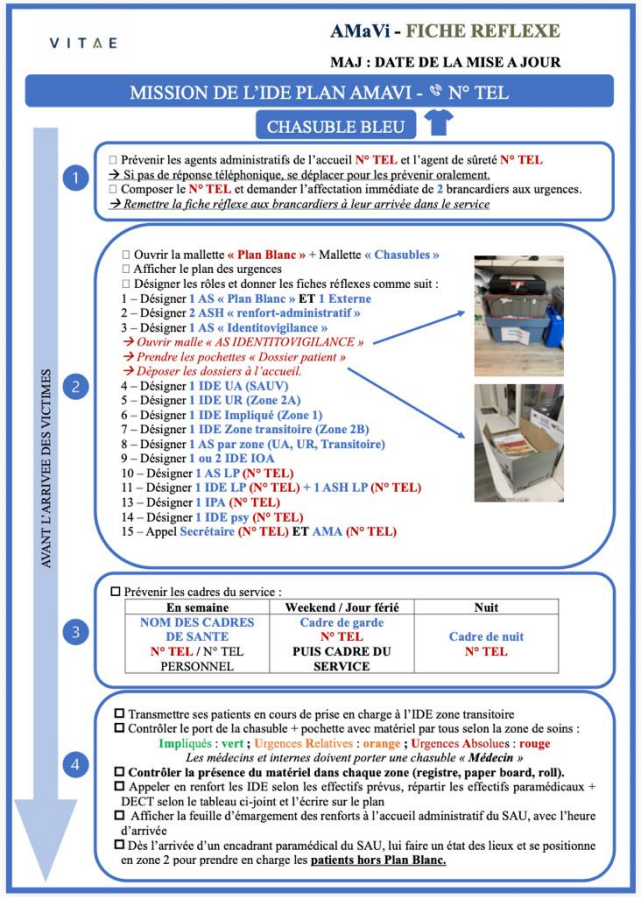
A L'ARRIVEE DES VICTIMES

4
- ☐ PEC des patients moribonds

VITAE FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Infirmier (IDE)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IDE PLAN AMAVI - N° TEL

CHASUBLE BLEU

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- ☐ Prévenir les agents administratifs de l'accueil **N° TEL** et l'agent de sûreté **N° TEL**
- → Si pas de réponse téléphonique, se déplacer pour les prévenir oralement.
- ☐ Composer le **N° TEL** et demander l'affectation immédiate de **2** brancardiers aux urgences.
- → *Remettre la fiche réflexe aux brancardiers à leur arrivée dans le service*

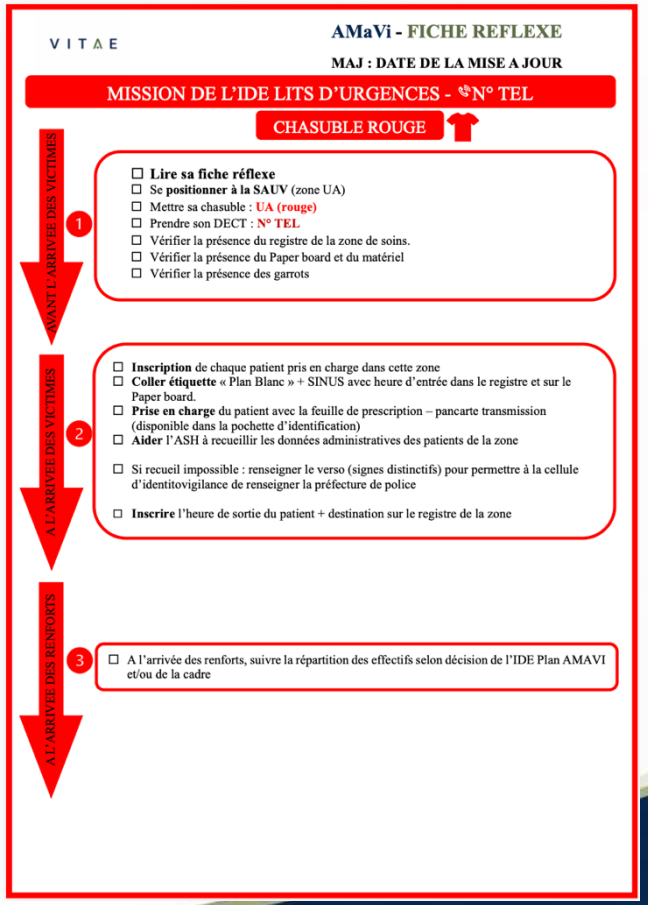
2
- ☐ Ouvrir la mallette **« Plan Blanc »** + Mallette **« Chasubles »**
- ☐ Afficher le plan des urgences
- ☐ Désigner les rôles et donner les fiches réflexes comme suit :

1 – Désigner **1 AS « Plan Blanc »** ET **1 Externe**
2 – Désigner **2 ASH « renfort-administratif »**
3 – Désigner **1 AS « Identitovigilance »**
→ *Ouvrir malle « AS IDENTITOVIGILANCE »*
→ *Prendre les pochettes « Dossier patient »*
→ *Déposer les dossiers à l'accueil.*
4 – Désigner **1 IDE UA (SAUV)**
5 – Désigner **1 IDE UR (Zone 2A)**
6 – Désigner **1 IDE Impliqué (Zone 1)**
7 – Désigner **1 IDE Zone transitoire (Zone 2B)**
8 – Désigner **1 AS par zone (UA, UR, Transitoire)**
9 – Désigner **1 ou 2 IDE IOA**
10 – Désigner **1 AS LP (N° TEL)**
11 – Désigner **1 IDE LP (N° TEL)** + **1 ASH LP (N° TEL)**
13 – Désigner **1 IPA (N° TEL)**
14 – Désigner **1 IDE psy (N° TEL)**
15 – Appel **Secrétaire (N° TEL)** ET **AMA (N° TEL)**

3
- ☐ Prévenir les cadres du service :

En semaine	Weekend / Jour férié	Nuit
NOM DES CADRES DE SANTE N° TEL / N° TEL PERSONNEL	Cadre de garde N° TEL PUIS CADRE DU SERVICE	Cadre de nuit N° TEL

4
- ☐ Transmettre ses patients en cours de prise en charge à l'IDE zone transitoire
- ☐ Contrôler le port de la chasuble + pochette avec matériel par tous selon la zone de soins :
  Impliqués : **vert** ; Urgences Relatives : **orange** ; Urgences Absolues : **rouge**
  *Les médecins et internes doivent porter une chasuble « **Médecin** »*
- ☐ **Contrôler la présence du matériel dans chaque zone (registre, paper board, roll).**
- ☐ Appeler en renfort les IDE selon les effectifs prévus, répartir les effectifs paramédicaux + DECT selon le tableau ci-joint et l'écrire sur le plan
- ☐ Afficher la feuille d'émargement des renforts à l'accueil administratif du SAU, avec l'heure d'arrivée
- ☐ Dès l'arrivée d'un encadrant paramédical du SAU, lui faire un état des lieux et se positionne en zone 2 pour prendre en charge les **patients hors Plan Blanc.**



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IDE LITS D'URGENCES - N° TEL

CHASUBLE ROUGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Se **positionner à la SAUV** (zone UA)
- ☐ Mettre sa chasuble : **UA (rouge)**
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**
- ☐ Vérifier la présence du registre de la zone de soins.
- ☐ Vérifier la présence du Paper board et du matériel
- ☐ Vérifier la présence des garrots

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2
- ☐ **Inscription** de chaque patient pris en charge dans cette zone
- ☐ **Coller étiquette** « Plan Blanc » + SINUS avec heure d'entrée dans le registre et sur le Paper board.
- ☐ **Prise en charge** du patient avec la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)
- ☐ **Aider** l'ASH à recueillir les données administratives des patients de la zone
- ☐ Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police
- ☐ **Inscrire** l'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

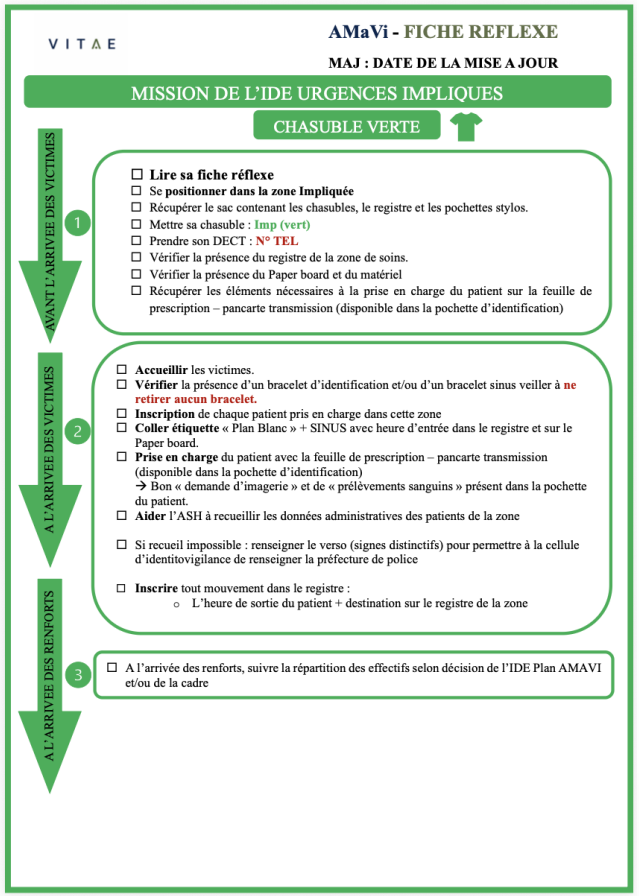
A L'ARRIVEE DES RENFORTS

3
- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision de l'IDE Plan AMAVI et/ou de la cadre

VITAE FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Infirmier (IDE)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IDE URGENCES IMPLIQUES

CHASUBLE VERTE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Se **positionner dans la zone Impliquée**
- ☐ Récupérer le sac contenant les chasubles, le registre et les pochettes stylos.
- ☐ Mettre sa chasuble : **Imp (vert)**
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**
- ☐ Vérifier la présence du registre de la zone de soins.
- ☐ Vérifier la présence du Paper board et du matériel
- ☐ Récupérer les éléments nécessaires à la prise en charge du patient sur la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

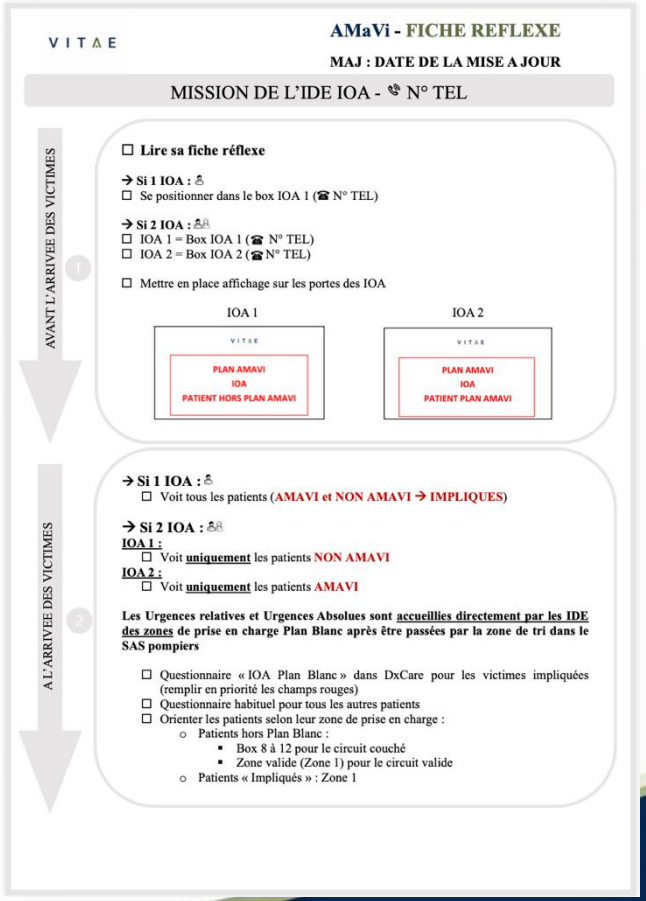
2

- ☐ **Accueillir** les victimes.
- ☐ **Vérifier** la présence d'un bracelet d'identification et/ou d'un bracelet sinus veiller à **ne retirer aucun bracelet.**
- ☐ **Inscription** de chaque patient pris en charge dans cette zone
- ☐ **Coller étiquette** « Plan Blanc » + SINUS avec heure d'entrée dans le registre et sur le Paper board.
- ☐ **Prise en charge** du patient avec la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)
  → Bon « demande d'imagerie » et de « prélèvements sanguins » présent dans la pochette du patient.
- ☐ **Aider** l'ASH à recueillir les données administratives des patients de la zone
- ☐ Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police
- ☐ **Inscrire** tout mouvement dans le registre :
  - L'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

A L'ARRIVEE DES RENFORTS

3

- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision de l'IDE Plan AMAVI et/ou de la cadre



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IDE IOA - N° TEL

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- ☐ **Lire sa fiche réflexe**

→ **Si 1 IOA :**
- ☐ Se positionner dans le box IOA 1 (☎ N° TEL)

→ **Si 2 IOA :**
- ☐ IOA 1 = Box IOA 1 (☎ N° TEL)
- ☐ IOA 2 = Box IOA 2 (☎ N° TEL)
- ☐ Mettre en place affichage sur les portes des IOA

IOA 1	IOA 2
VITAE PLAN AMAVI IOA PATIENT HORS PLAN AMAVI	VITAE PLAN AMAVI IOA PATIENT PLAN AMAVI

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2

→ **Si 1 IOA :**
- ☐ Voit tous les patients (**AMAVI et NON AMAVI → IMPLIQUES**)

→ **Si 2 IOA :**

IOA 1 :
- ☐ Voit **uniquement** les patients **NON AMAVI**

IOA 2 :
- ☐ Voit **uniquement** les patients **AMAVI**

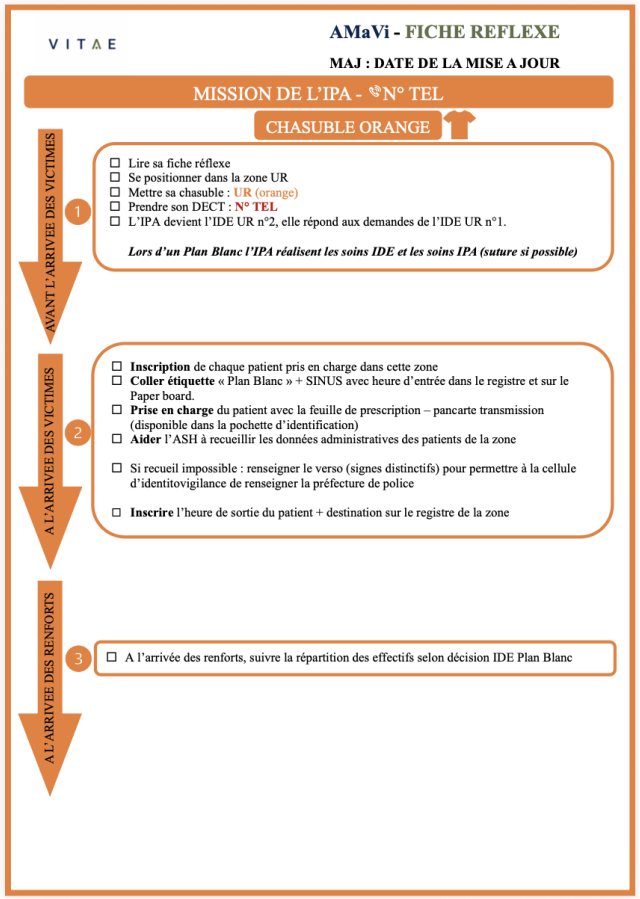
Les Urgences relatives et Urgences Absolues sont accueillies directement par les IDE des zones de prise en charge Plan Blanc après être passées par la zone de tri dans le SAS pompiers

- ☐ Questionnaire « IOA Plan Blanc » dans DxCare pour les victimes impliquées (remplir en priorité les champs rouges)
- ☐ Questionnaire habituel pour tous les autres patients
- ☐ Orienter les patients selon leur zone de prise en charge :
  - Patients hors Plan Blanc :
    - Box 8 à 12 pour le circuit couché
    - Zone valide (Zone 1) pour le circuit valide
  - Patients « Impliqués » : Zone 1

VITAE
FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Infirmier de pratiques avancées (IPA)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'IPA - ☎N° TEL

CHASUBLE ORANGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- ☐ Lire sa fiche réflexe
- ☐ Se positionner dans la zone UR
- ☐ Mettre sa chasuble : UR (orange)
- ☐ Prendre son DECT : **N° TEL**
- ☐ L'IPA devient l'IDE UR n°2, elle répond aux demandes de l'IDE UR n°1.

Lors d'un Plan Blanc l'IPA réalisent les soins IDE et les soins IPA (suture si possible)

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

2
- ☐ **Inscription** de chaque patient pris en charge dans cette zone
- ☐ **Coller étiquette** « Plan Blanc » + SINUS avec heure d'entrée dans le registre et sur le Paper board.
- ☐ **Prise en charge** du patient avec la feuille de prescription – pancarte transmission (disponible dans la pochette d'identification)
- ☐ **Aider** l'ASH à recueillir les données administratives des patients de la zone
- ☐ Si recueil impossible : renseigner le verso (signes distinctifs) pour permettre à la cellule d'identitovigilance de renseigner la préfecture de police
- ☐ **Inscrire** l'heure de sortie du patient + destination sur le registre de la zone

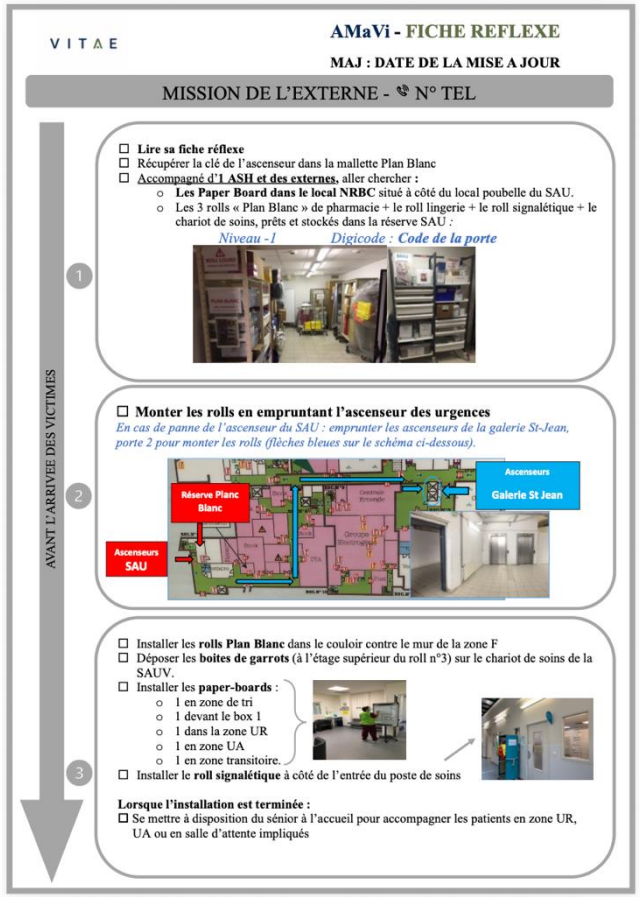
A L'ARRIVEE DES RENFORTS

3
- ☐ A l'arrivée des renforts, suivre la répartition des effectifs selon décision IDE Plan Blanc

VITAE
FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Externe en médecine



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE LA MISE A JOUR

MISSION DE L'EXTERNE - ✆ N° TEL

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- ☐ **Lire sa fiche réflexe**
- ☐ Récupérer la clé de l'ascenseur dans la mallette Plan Blanc
- ☐ Accompagné d'**1 ASH et des externes**, aller chercher :
  - **Les Paper Board dans le local NRBC** situé à côté du local poubelle du SAU.
  - Les 3 rolls « Plan Blanc » de pharmacie + le roll lingerie + le roll signalétique + le chariot de soins, prêts et stockés dans la réserve SAU :

Niveau -1 *Digicode : **Code de la porte***

2
- ☐ **Monter les rolls en empruntant l'ascenseur des urgences**

En cas de panne de l'ascenseur du SAU : emprunter les ascenseurs de la galerie St-Jean, porte 2 pour monter les rolls (flèches bleues sur le schéma ci-dessous).

Réserve Planc Blanc
Ascenseurs Galerie St Jean
Ascenseurs SAU

3
- ☐ Installer les **rolls Plan Blanc** dans le couloir contre le mur de la zone F
- ☐ Déposer les **boites de garrots** (à l'étage supérieur du roll n°3) sur le chariot de soins de la SAUV.
- ☐ Installer les **paper-boards** :
  - 1 en zone de tri
  - 1 devant le box 1
  - 1 dans la zone UR
  - 1 en zone UA
  - 1 en zone transitoire.
- ☐ Installer le **roll signalétique** à côté de l'entrée du poste de soins

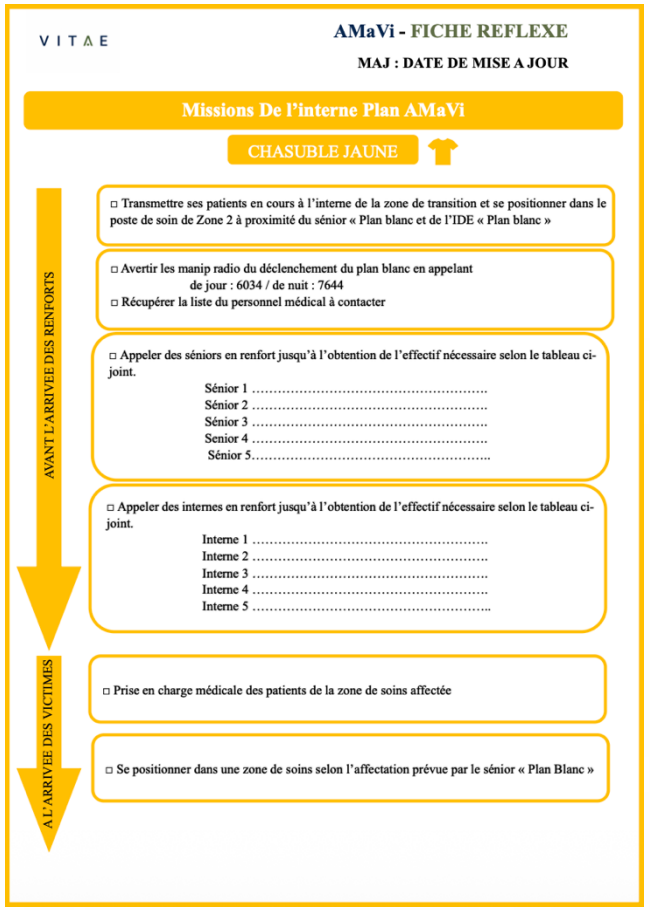
Lorsque l'installation est terminée :

☐ Se mettre à disposition du sénior à l'accueil pour accompagner les patients en zone UR, UA ou en salle d'attente impliqués

VITAE FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Interne en médecine



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

Missions De l'interne Plan AMaVi

CHASUBLE JAUNE

AVANT L'ARRIVEE DES RENFORTS

- □ Transmettre ses patients en cours à l'interne de la zone de transition et se positionner dans le poste de soin de Zone 2 à proximité du sénior « Plan blanc et de l'IDE « Plan blanc »
- □ Avertir les manip radio du déclenchement du plan blanc en appelant de jour : 6034 / de nuit : 7644
- □ Récupérer la liste du personnel médical à contacter
- □ Appeler des séniors en renfort jusqu'à l'obtention de l'effectif nécessaire selon le tableau ci-joint.
  - Sénior 1 .....
  - Sénior 2 .....
  - Sénior 3 .....
  - Senior 4 .....
  - Sénior 5.....
- □ Appeler des internes en renfort jusqu'à l'obtention de l'effectif nécessaire selon le tableau ci-joint.
  - Interne 1 .....
  - Interne 2 .....
  - Interne 3 .....
  - Interne 4 .....
  - Interne 5 .....

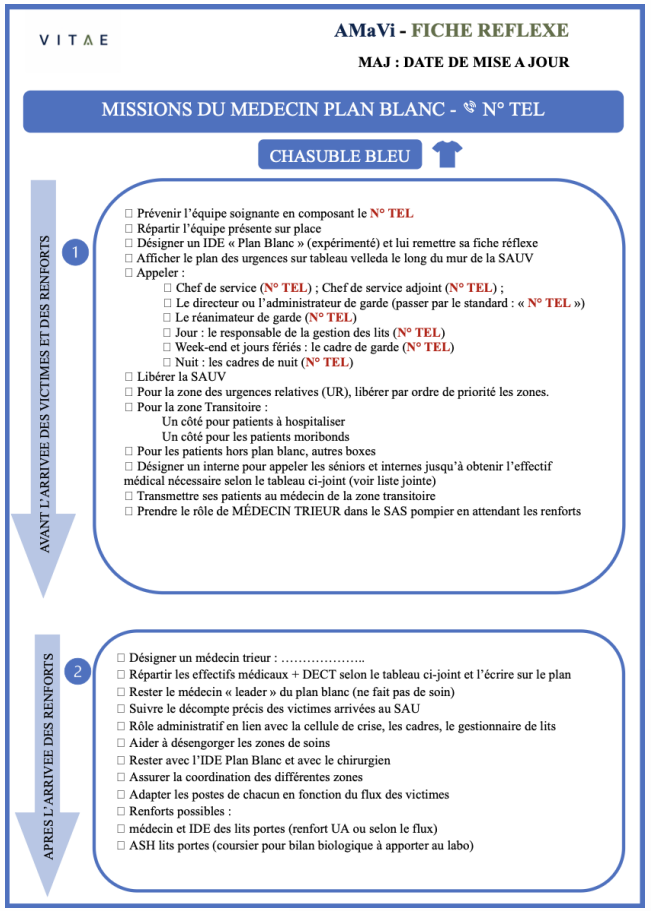
A L'ARRIVEE DES VICTIMES

- □ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée
- □ Se positionner dans une zone de soins selon l'affectation prévue par le sénior « Plan Blanc »

VITAE FORMATION SANTÉ

Les rôles et missions des différents professionnels

Médecin



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSIONS DU MEDECIN PLAN BLANC - N° TEL

CHASUBLE BLEU

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

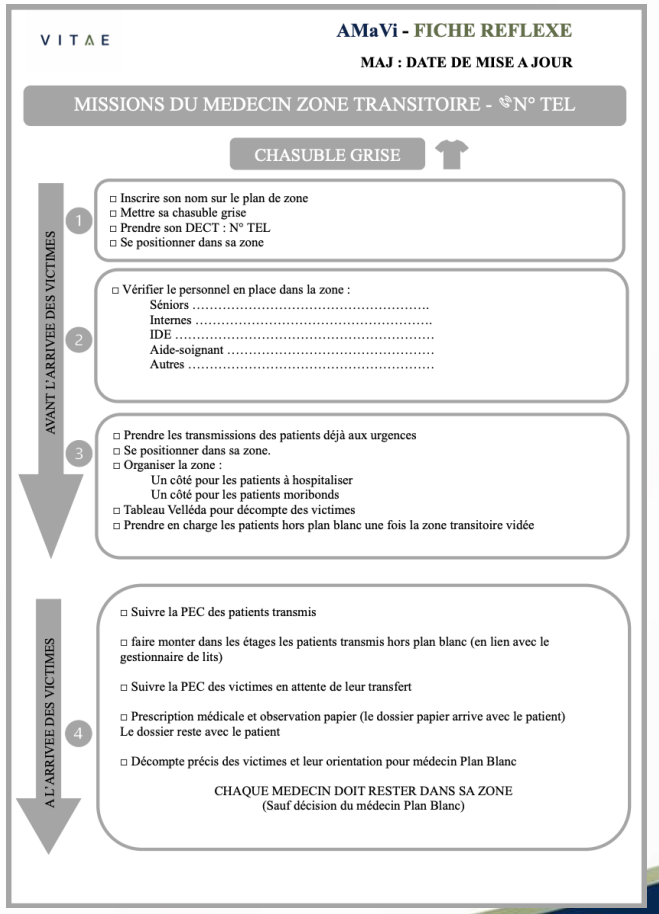
1

- ☐ Prévenir l'équipe soignante en composant le N° TEL
- ☐ Répartir l'équipe présente sur place
- ☐ Désigner un IDE « Plan Blanc » (expérimenté) et lui remettre sa fiche réflexe
- ☐ Afficher le plan des urgences sur tableau velleda le long du mur de la SAUV
- ☐ Appeler :
  - ☐ Chef de service (N° TEL) ; Chef de service adjoint (N° TEL) ;
  - ☐ Le directeur ou l'administrateur de garde (passer par le standard : « N° TEL »)
  - ☐ Le réanimateur de garde (N° TEL)
  - ☐ Jour : le responsable de la gestion des lits (N° TEL)
  - ☐ Week-end et jours fériés : le cadre de garde (N° TEL)
  - ☐ Nuit : les cadres de nuit (N° TEL)
- ☐ Libérer la SAUV
- ☐ Pour la zone des urgences relatives (UR), libérer par ordre de priorité les zones.
- ☐ Pour la zone Transitoire :
  - Un côté pour patients à hospitaliser
  - Un côté pour les patients moribonds
- ☐ Pour les patients hors plan blanc, autres boxes
- ☐ Désigner un interne pour appeler les séniors et internes jusqu'à obtenir l'effectif médical nécessaire selon le tableau ci-joint (voir liste jointe)
- ☐ Transmettre ses patients au médecin de la zone transitoire
- ☐ Prendre le rôle de MÉDECIN TRIEUR dans le SAS pompier en attendant les renforts

APRES L'ARRIVEE DES RENFORTS

2

- ☐ Désigner un médecin trieur : ……..
- ☐ Répartir les effectifs médicaux + DECT selon le tableau ci-joint et l'écrire sur le plan
- ☐ Rester le médecin « leader » du plan blanc (ne fait pas de soin)
- ☐ Suivre le décompte précis des victimes arrivées au SAU
- ☐ Rôle administratif en lien avec la cellule de crise, les cadres, le gestionnaire de lits
- ☐ Aider à désengorger les zones de soins
- ☐ Rester avec l'IDE Plan Blanc et avec le chirurgien
- ☐ Assurer la coordination des différentes zones
- ☐ Adapter les postes de chacun en fonction du flux des victimes
- ☐ Renforts possibles :
- ☐ médecin et IDE des lits portes (renfort UA ou selon le flux)
- ☐ ASH lits portes (coursier pour bilan biologique à apporter au labo)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSIONS DU MEDECIN ZONE TRANSITOIRE - N° TEL

CHASUBLE GRISE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

- ☐ Inscrire son nom sur le plan de zone
- ☐ Mettre sa chasuble grise
- ☐ Prendre son DECT : N° TEL
- ☐ Se positionner dans sa zone

2

- ☐ Vérifier le personnel en place dans la zone :
  - Séniors ……
  - Internes ……
  - IDE ……
  - Aide-soignant ……
  - Autres ……

3

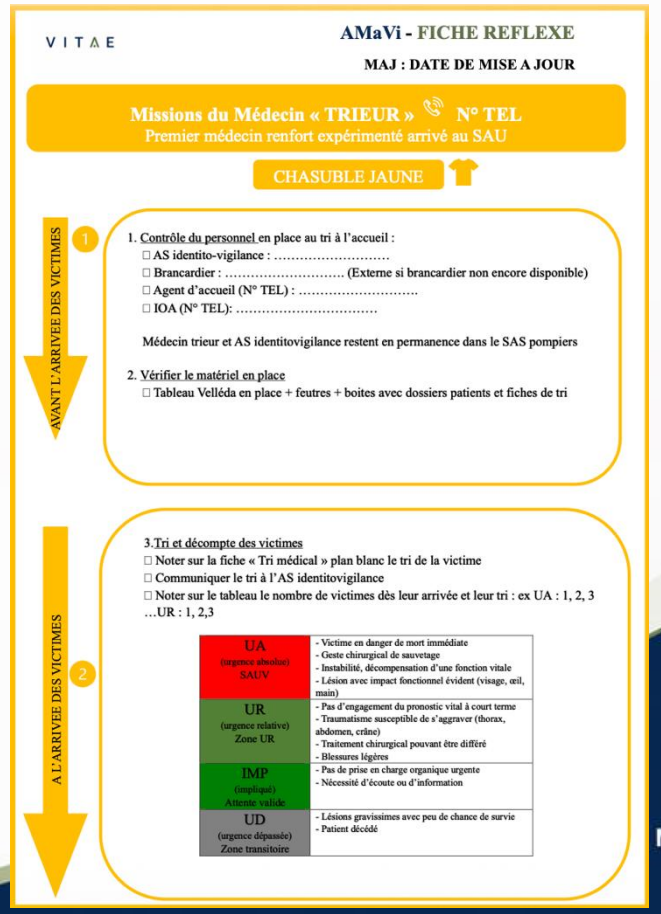
- ☐ Prendre les transmissions des patients déjà aux urgences
- ☐ Se positionner dans sa zone.
- ☐ Organiser la zone :
  - Un côté pour les patients à hospitaliser
  - Un côté pour les patients moribonds
- ☐ Tableau Velléda pour décompte des victimes
- ☐ Prendre en charge les patients hors plan blanc une fois la zone transitoire vidée

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

4

- ☐ Suivre la PEC des patients transmis
- ☐ faire monter dans les étages les patients transmis hors plan blanc (en lien avec le gestionnaire de lits)
- ☐ Suivre la PEC des victimes en attente de leur transfert
- ☐ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient) Le dossier reste avec le patient
- ☐ Décompte précis des victimes et leur orientation pour médecin Plan Blanc

CHAQUE MEDECIN DOIT RESTER DANS SA ZONE
(Sauf décision du médecin Plan Blanc)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

Missions du Médecin « TRIEUR » N° TEL
Premier médecin renfort expérimenté arrivé au SAU

CHASUBLE JAUNE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1

1. Contrôle du personnel en place au tri à l'accueil :
   - ☐ AS identito-vigilance : ……
   - ☐ Brancardier : …… (Externe si brancardier non encore disponible)
   - ☐ Agent d'accueil (N° TEL) : ……
   - ☐ IOA (N° TEL): ……

Médecin trieur et AS identitovigilance restent en permanence dans le SAS pompiers

2. Vérifier le matériel en place
   - ☐ Tableau Velléda en place + feutres + boites avec dossiers patients et fiches de tri

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

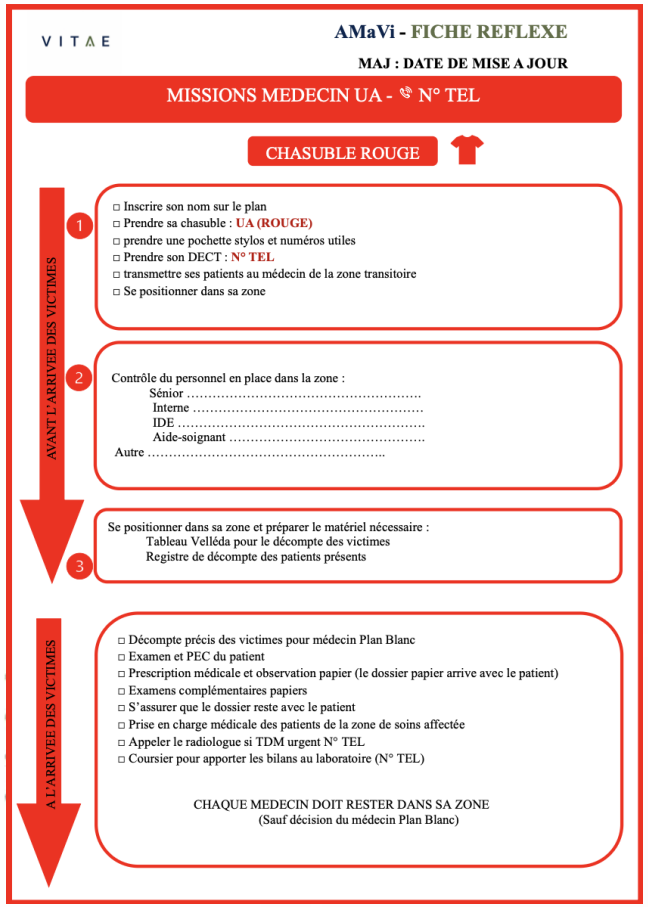
2

3. Tri et décompte des victimes
   - ☐ Noter sur la fiche « Tri médical » plan blanc le tri de la victime
   - ☐ Communiquer le tri à l'AS identitovigilance
   - ☐ Noter sur le tableau le nombre de victimes dès leur arrivée et leur tri : ex UA : 1, 2, 3 …UR : 1, 2,3

UA (urgence absolue) SAUV	- Victime en danger de mort immédiate - Geste chirurgical de sauvetage - Instabilité, décompensation d'une fonction vitale - Lésion avec impact fonctionnel évident (visage, œil, main)
UR (urgence relative) Zone UR	- Pas d'engagement du pronostic vital à court terme - Traumatisme susceptible de s'aggraver (thorax, abdomen, crâne) - Traitement chirurgical pouvant être différé - Blessures légères
IMP (impliqué) Attente valide	- Pas de prise en charge organique urgente - Nécessité d'écoute ou d'information
UD (urgence dépassée) Zone transitoire	- Lésions gravissimes avec peu de chance de survie - Patient décédé

Les rôles et missions des différents professionnels

Médecin



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSIONS MEDECIN UA - N° TEL

CHASUBLE ROUGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- □ Inscrire son nom sur le plan
- □ Prendre sa chasuble : UA (ROUGE)
- □ prendre une pochette stylos et numéros utiles
- □ Prendre son DECT : N° TEL
- □ transmettre ses patients au médecin de la zone transitoire
- □ Se positionner dans sa zone

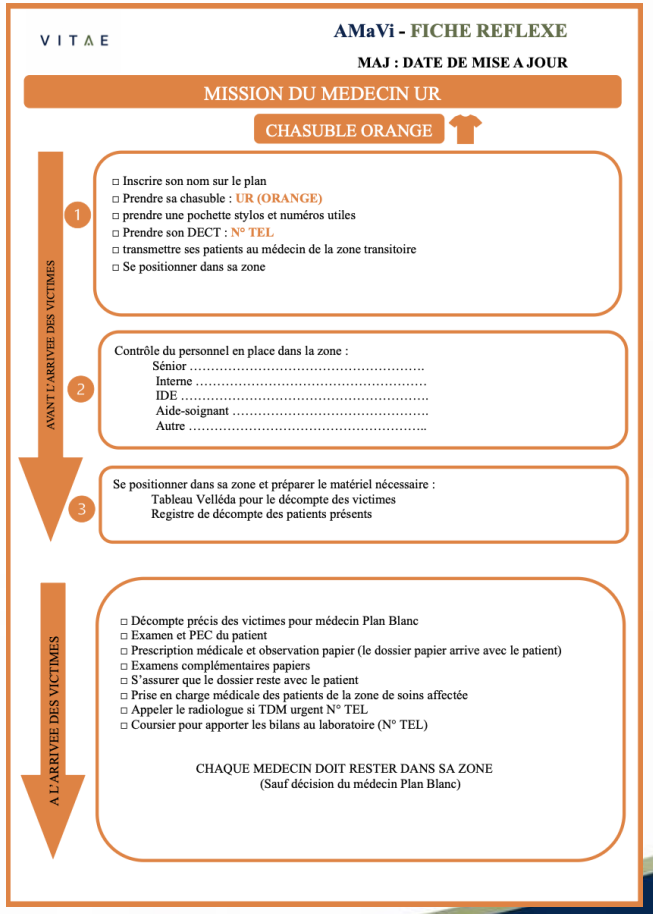
2
Contrôle du personnel en place dans la zone :
- Sénior ……
- Interne ……
- IDE ……
- Aide-soignant ……

Autre ……

3
Se positionner dans sa zone et préparer le matériel nécessaire :
- Tableau Velléda pour le décompte des victimes
- Registre de décompte des patients présents

A L'ARRIVEE DES VICTIMES
- □ Décompte précis des victimes pour médecin Plan Blanc
- □ Examen et PEC du patient
- □ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient)
- □ Examens complémentaires papiers
- □ S'assurer que le dossier reste avec le patient
- □ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée
- □ Appeler le radiologue si TDM urgent N° TEL
- □ Coursier pour apporter les bilans au laboratoire (N° TEL)

CHAQUE MEDECIN DOIT RESTER DANS SA ZONE
(Sauf décision du médecin Plan Blanc)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSION DU MEDECIN UR

CHASUBLE ORANGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

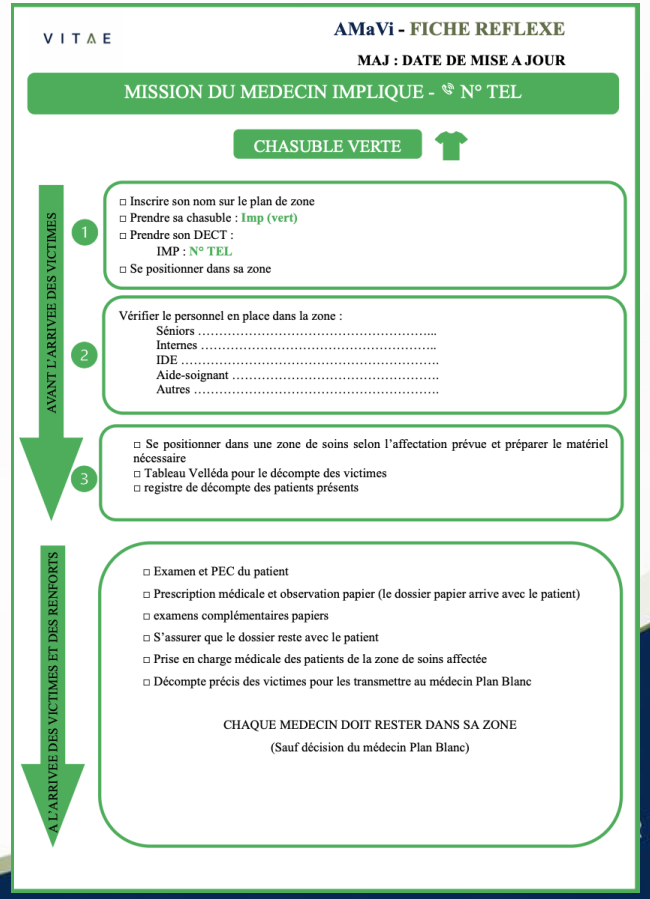
1
- □ Inscrire son nom sur le plan
- □ Prendre sa chasuble : UR (ORANGE)
- □ prendre une pochette stylos et numéros utiles
- □ Prendre son DECT : N° TEL
- □ transmettre ses patients au médecin de la zone transitoire
- □ Se positionner dans sa zone

2
Contrôle du personnel en place dans la zone :
- Sénior ……
- Interne ……
- IDE ……
- Aide-soignant ……
- Autre ……

3
Se positionner dans sa zone et préparer le matériel nécessaire :
- Tableau Velléda pour le décompte des victimes
- Registre de décompte des patients présents

A L'ARRIVEE DES VICTIMES
- □ Décompte précis des victimes pour médecin Plan Blanc
- □ Examen et PEC du patient
- □ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient)
- □ Examens complémentaires papiers
- □ S'assurer que le dossier reste avec le patient
- □ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée
- □ Appeler le radiologue si TDM urgent N° TEL
- □ Coursier pour apporter les bilans au laboratoire (N° TEL)

CHAQUE MEDECIN DOIT RESTER DANS SA ZONE
(Sauf décision du médecin Plan Blanc)



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSION DU MEDECIN IMPLIQUE - N° TEL

CHASUBLE VERTE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

1
- □ Inscrire son nom sur le plan de zone
- □ Prendre sa chasuble : Imp (vert)
- □ Prendre son DECT :
  IMP : N° TEL
- □ Se positionner dans sa zone

2
Vérifier le personnel en place dans la zone :
- Séniors ……
- Internes ……
- IDE ……
- Aide-soignant ……
- Autres ……

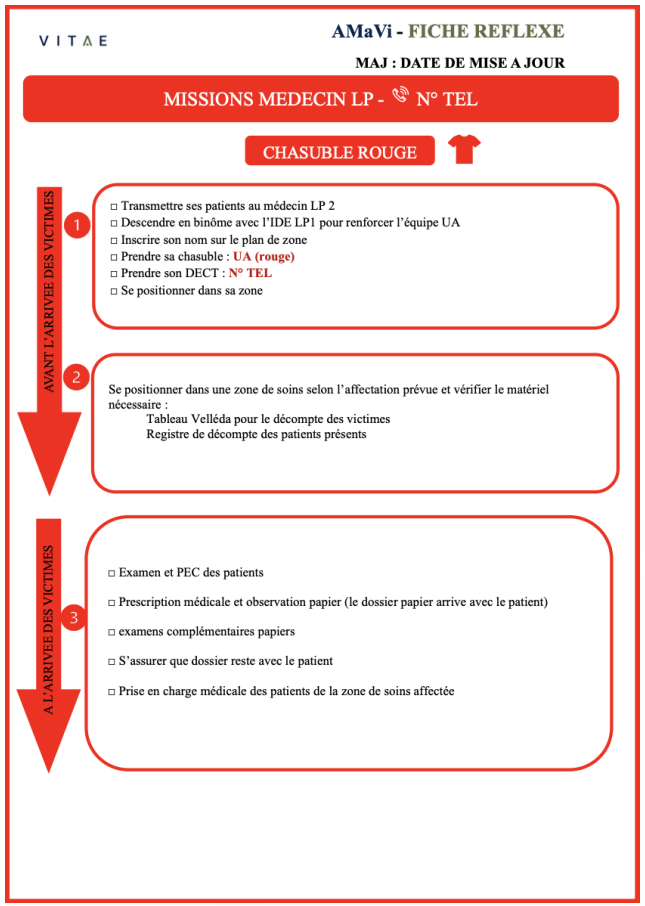
3
- □ Se positionner dans une zone de soins selon l'affectation prévue et préparer le matériel nécessaire
- □ Tableau Velléda pour le décompte des victimes
- □ registre de décompte des patients présents

A L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS
- □ Examen et PEC du patient
- □ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient)
- □ examens complémentaires papiers
- □ S'assurer que le dossier reste avec le patient
- □ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée
- □ Décompte précis des victimes pour les transmettre au médecin Plan Blanc

CHAQUE MEDECIN DOIT RESTER DANS SA ZONE
(Sauf décision du médecin Plan Blanc)

Les rôles et missions des différents professionnels

Médecin



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSIONS MEDECIN LP - N° TEL

CHASUBLE ROUGE

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES

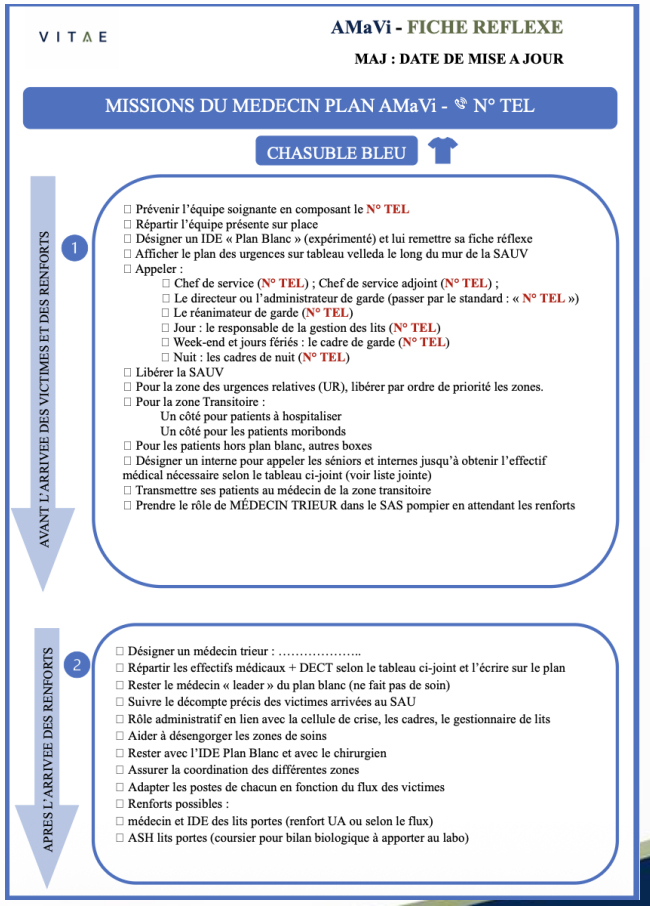
1
- □ Transmettre ses patients au médecin LP 2
- □ Descendre en binôme avec l'IDE LP1 pour renforcer l'équipe UA
- □ Inscrire son nom sur le plan de zone
- □ Prendre sa chasuble : **UA (rouge)**
- □ Prendre son DECT : **N° TEL**
- □ Se positionner dans sa zone

2

Se positionner dans une zone de soins selon l'affectation prévue et vérifier le matériel nécessaire :
- Tableau Velléda pour le décompte des victimes
- Registre de décompte des patients présents

A L'ARRIVEE DES VICTIMES

3
- □ Examen et PEC des patients
- □ Prescription médicale et observation papier (le dossier papier arrive avec le patient)
- □ examens complémentaires papiers
- □ S'assurer que dossier reste avec le patient
- □ Prise en charge médicale des patients de la zone de soins affectée



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

MISSIONS DU MEDECIN PLAN AMaVi - N° TEL

CHASUBLE BLEU

AVANT L'ARRIVEE DES VICTIMES ET DES RENFORTS

1
- □ Prévenir l'équipe soignante en composant le **N° TEL**
- □ Répartir l'équipe présente sur place
- □ Désigner un IDE « Plan Blanc » (expérimenté) et lui remettre sa fiche réflexe
- □ Afficher le plan des urgences sur tableau velleda le long du mur de la SAUV
- □ Appeler :
  - □ Chef de service (**N° TEL**) ; Chef de service adjoint (**N° TEL**) ;
  - □ Le directeur ou l'administrateur de garde (passer par le standard : « **N° TEL** »)
  - □ Le réanimateur de garde (**N° TEL**)
  - □ Jour : le responsable de la gestion des lits (**N° TEL**)
  - □ Week-end et jours fériés : le cadre de garde (**N° TEL**)
  - □ Nuit : les cadres de nuit (**N° TEL**)
- □ Libérer la SAUV
- □ Pour la zone des urgences relatives (UR), libérer par ordre de priorité les zones.
- □ Pour la zone Transitoire :
  - Un côté pour patients à hospitaliser
  - Un côté pour les patients moribonds
- □ Pour les patients hors plan blanc, autres boxes
- □ Désigner un interne pour appeler les séniors et internes jusqu'à obtenir l'effectif médical nécessaire selon le tableau ci-joint (voir liste jointe)
- □ Transmettre ses patients au médecin de la zone transitoire
- □ Prendre le rôle de MÉDECIN TRIEUR dans le SAS pompier en attendant les renforts

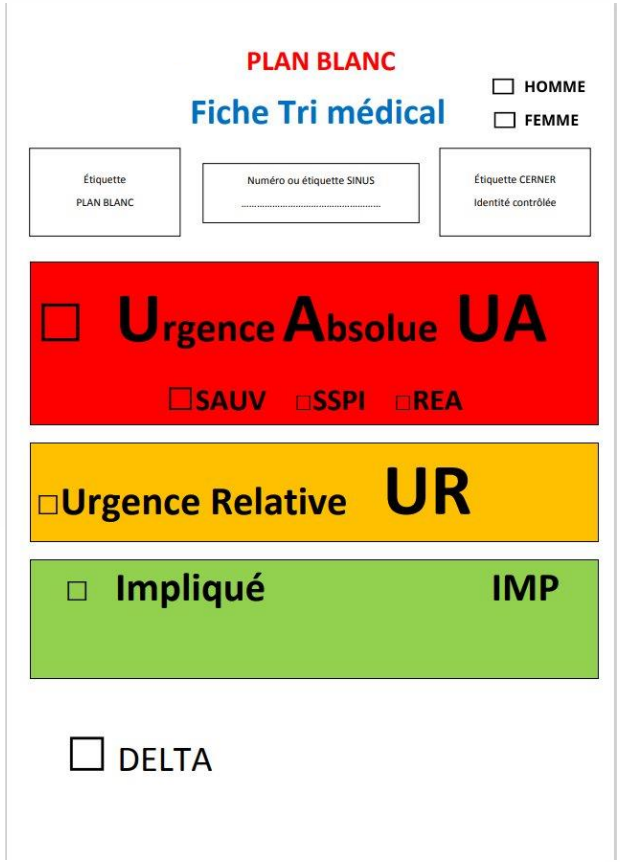
APRES L'ARRIVEE DES RENFORTS

2
- □ Désigner un médecin trieur : ……..
- □ Répartir les effectifs médicaux + DECT selon le tableau ci-joint et l'écrire sur le plan
- □ Rester le médecin « leader » du plan blanc (ne fait pas de soin)
- □ Suivre le décompte précis des victimes arrivées au SAU
- □ Rôle administratif en lien avec la cellule de crise, les cadres, le gestionnaire de lits
- □ Aider à désengorger les zones de soins
- □ Rester avec l'IDE Plan Blanc et avec le chirurgien
- □ Assurer la coordination des différentes zones
- □ Adapter les postes de chacun en fonction du flux des victimes
- □ Renforts possibles :
- □ médecin et IDE des lits portes (renfort UA ou selon le flux)
- □ ASH lits portes (coursier pour bilan biologique à apporter au labo)

VITAE FORMATION SANTÉ

Procédures spécifiques à un AMaVi

Documents papiers :


PLAN BLANC

Fiche Tri médical

☐ HOMME
☐ FEMME

Étiquette PLAN BLANC

Numéro ou étiquette SINUS

Étiquette CERNER Identité contrôlée

☐ Urgence Absolue UA

☐SAUV ☐SSPI ☐REA

☐Urgence Relative UR

☐ Impliqué IMP

☐ DELTA

1 Fiche de tri médical

UA (urgence absolue)	•Victime en danger de mort immédiate •Geste chirurgical de sauvetage •Instabilité, décompensation d'une fonction vitale •Lésion avec impact fonctionnel évident (visage, œil, main)
UR (Urgence relative)	•Pas d'engagement du pronostic vital à court terme •Traumatisme susceptible de s'aggraver (thorax, abdomen, crâne) •Traitement chirurgical pouvant être différé •Blessures légères
IMP (Impliqué)	•Pas de prise en charge organique urgente •Nécessité d'écoute ou d'information
UD ou DELTA (Urgence dépassée)	•Lésions gravissimes avec peu de chance de survie •Patient décédé

VITAE FORMATION SANTÉ

Procédures spécifiques à un AMaVi

Identification des victimes

SI-VIC

Système d'**I**nformation pour le suivi des **VIC**times d'attentats et de situations sanitaires exceptionnelles
SI-VIC est déclenché lors d'évènements et de catastrophes. Il est interconnecté avecSINUS (outil pompier)

- Il permet de renseigner et de mettre à jour les informations relatives à :
  - L'identité du patient pris en charge ;
  - La prise en charge (hospitalière ou médico-psychologique) du patient ;
  - La personne à contacter, proche du patient.

Il est accessible via un site web sécurisé pour les établissements de santé, SAMU, ARS, mais aussi, la Cellules d'Urgences Médico-Psychologiques)

VITAE
FORMATION SANTÉ

Procédures spécifiques à un AMaVi

Identification des victimes

Bracelet SINUS

- Mis en place par les secours en pré-hospitalier
- Système d'information numérique standardisé (en lien avec SI-VIC)
- Le système SINUS permet le recensement et le suivi des victimes

Il permet d'établir rapidement un bilan chiffré proche de la réalité et de classer ces données par spécificité : tranches d'âges, sexe, nationalité, domicile, lieu d'hospitalisation, etc.

Le format du numéro SINUS se compose de 21 caractères :
Exemple : FR240NOVI0000TR500001



VITAE
FORMATION SANTÉ

Procédures spécifiques à un AMaVi

Identification des victimes

Bracelet identité plan AMaVi

- Mis en place par l'équipe de tri
- Système d'identification intrahospitalier (en lien avec le logiciel informatique utilisé dans l'établissement)

Il permet de sécurisé l'entrée des victimes dans le service et de relié l'identité SINUS (extrahospitalier) à une identité AMaVi (intrahospitalier).

Le format du numéro AMaVi se compose des mentions PB suivie de numéros :
Exemple : PB00000000001



VITAE
FORMATION SANTÉ

Procédures spécifiques à un AMaVi

Identification des victimes

Bracelet identité vérifié

- Mis en place par les soignants prenant en charge le patient dans les zones de soins ou dans les services.
- Système d'identification intrahospitalier (également en lien avec le logiciel informatique utilisé dans l'établissement).

Il est mis en place dans un second temps, après avoir vérifié et/ou identifié la victime

Le format du bracelet est le même que tous les autres bracelets d'identification.
Il comprend, le nom, le prénom, le sexe, et la date de naissance.
Exemple : DUPOND Jacque (M), 06/09/1956



VITAE
FORMATION SANTÉ

Procédures spécifiques à un AMaVi

Identification des victimes

Une victime peut donc se retrouver avec 2 ou 3 bracelets au cours de sa prise en charge



Sans identité contrôlée



Avec identité contrôlée

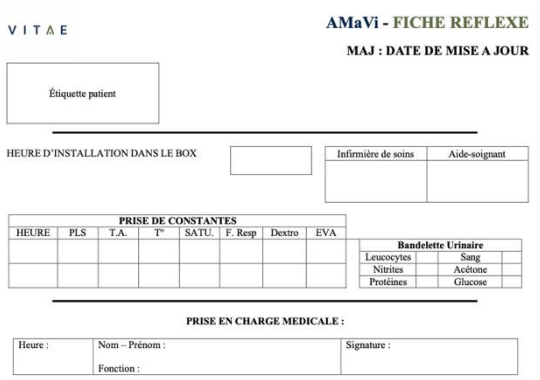
Ne jamais couper un bracelet d'identification

VITAE
FORMATION SANTÉ

Procédures spécifiques à un AMaVi

Documents papiers :

2 Fiche d'observation médicale



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

Étiquette patient

HEURE D'INSTALLATION DANS LE BOX

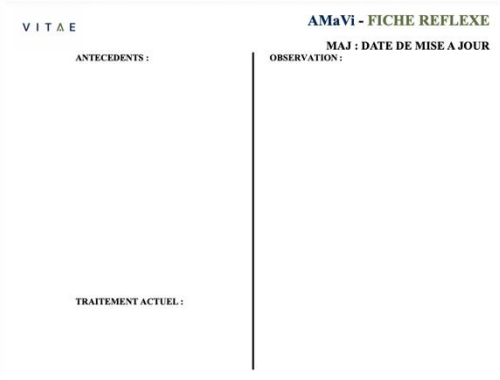
Infirmière de soins	Aide-soignant

PRISE DE CONSTANTES							
HEURE	PLS	T.A.	T°	SATU.	F. Resp	Dextro	EVA

Bandelette Urinaire			
Leucocytes		Sang	
Nitrites		Acétone	
Protéines		Glucose	

PRISE EN CHARGE MEDICALE :

Heure :	Nom – Prénom : Fonction :	Signature :



VITAE

AMaVi - FICHE REFLEXE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

ANTECEDENTS :

OBSERVATION :

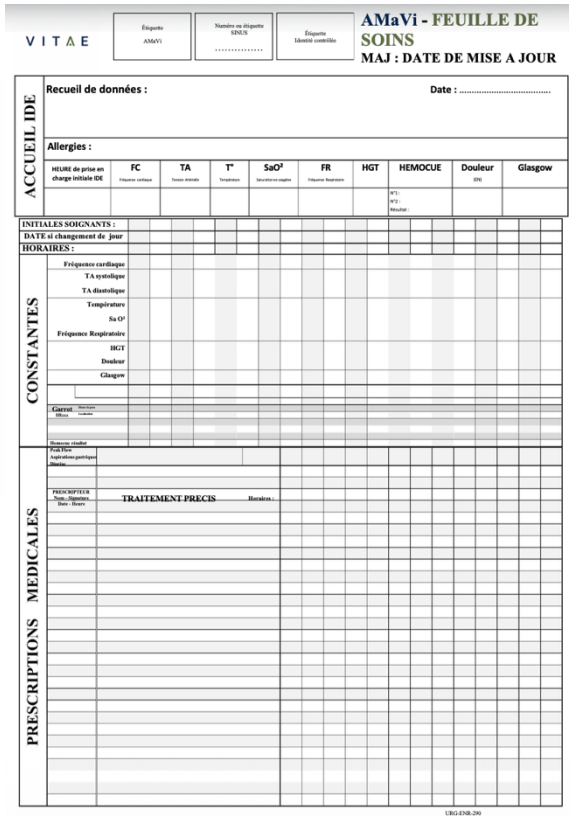
TRAITEMENT ACTUEL :

VITAE FORMATION SANTÉ

Procédures spécifiques à un AMaVi

Documents papiers :

3 Fiche pancarte = dossier de soins


VITAE

AMaVi - FEUILLE DE SOINS

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

ACCUEIL IDE

Recueil de données : Date : .....

Allergies :

HEURE de prise en charge initiale IDE	FC	TA	T°	SaO²	FR	HGT	HEMOCUE	Douleur	Glasgow
							N°1 : N°2 : Résultat :		

INITIALES SOIGNANTS :

DATE si changement de jour

HORAIRES :

CONSTANTES

Fréquence cardiaque

TA systolique

TA diastolique

Température

Sa O²

Fréquence Respiratoire

HGT

Douleur

Glasgow

Garrot

Hémocue réalisé

PRESCRIPTIONS MEDICALES

Prob Hem

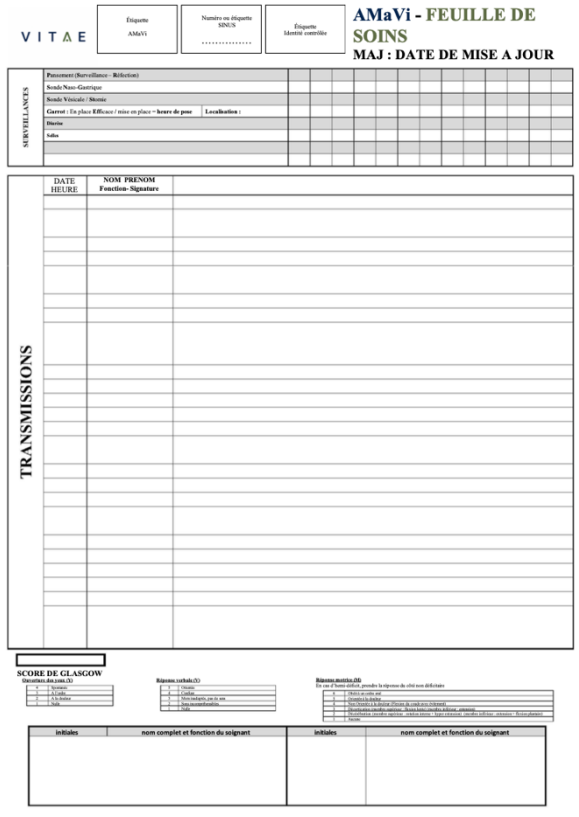
Aspirations gastriques

Diurèse

PRESCRIPTEUR Nom - Signature Date - Heure

TRAITEMENT PRECIS Horaires :

URG-ENR-290


VITAE

AMaVi - FEUILLE DE SOINS

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

SURVEILLANCES

| | | | | | | |

Procédures spécifiques à un AMaVi

Documents papiers :

4 Fiche recueil de données administrative

VITAE

AMaVi - FICHE DE RECUEIL ADMINISTRATIF

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

Fiche de recueil administratif

Étiquette AMaVi	Numéro ou étiquette SINUS	Étiquette Identité contrôlée

NOM DE NAISSANCE : .....

NOM USUEL : .....

PRENOM : .....

Sexe : .....

Date de Naissance : .....

Si mineur, NOM DES PARENTS : .....

En cas de recueil impossible voir au verso

Personne à prévenir : .....

☞ Téléphone : .....

Accompagnant présent □ .....

☐ PIECE D'IDENTITE ☐ CARTE VITALE

☐ INCONSCIENT(E)

☐ PARTI(E) AU BLOC OPERATOIRE

☐ PARTI(E) EN REANIMATION

☐ PARTI(E) (indiquer la destination si connue) :

☐ TRANSFERT (indiquer le service) :

☐ DELTA

ECRIRE TRES LISIBLEMENT SVP

URG-ENR-289

En cas de recueil de données impossible, description des signes distinctifs

Type :

□ caucasien
□ méditerranéen
□ africain
□ moyen-oriental
□ asiatique
□ indo-pakistanais
□ latino-américain
□ autre :

Cheveux : Couleur : □longs □courts □rasés

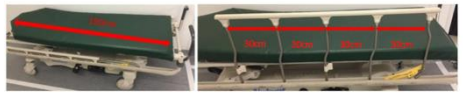
Yeux : Couleur :

Porteur de lunettes : □ oui □ non Porteur de verre de contact : □ oui □ non

Poids approximatif :

Taille approximative :

Pour vous aider à évaluer :



Signes particuliers distinctifs : (cicatrices, tatouages, piercing ...)

ECRIRE TRES LISIBLEMENT SVP

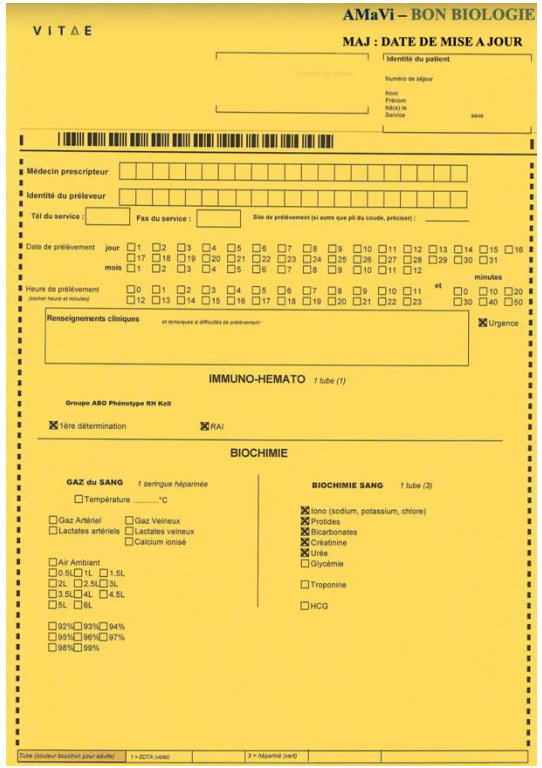
VITAE FORMATION SANTÉ

Procédures spécifiques à un AMaVi

Documents papiers :

4 Autres documents

Bon laboratoire



AMaVi – BON BIOLOGIE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

VITAE

Identité du patient

Numéro de séjour

Nom
Prénom
Né(e) le
Service
sexe

Médecin prescripteur

Identité du préleveur

Tél du service : Fax du service : Site de prélèvement (si autre que pli du coude, préciser) :

Date de prélèvement jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Heure de prélèvement (locher heure et minutes) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 et 0 10 20 30 40 50 minutes

Renseignements cliniques et remarques si difficultés de prélèvement :

☒ Urgence

IMMUNO-HEMATO 1 tube (1)

Groupe ABO Phénotype RH Kell

☒ 1ère détermination ☒ RAI

BIOCHIMIE

GAZ du SANG 1 seringue héparinée

☐ Température .....°C

☐ Gaz Artériel ☐ Gaz Veineux
☐ Lactates artériels ☐ Lactates veineux
☐ Calcium ionisé

☐ Air Ambiant
☐ 0.5L ☐ 1L ☐ 1.5L
☐ 2L ☐ 2.5L ☐ 3L
☐ 3.5L ☐ 4L ☐ 4.5L
☐ 5L ☐ 6L

☐ 92% ☐ 93% ☐ 94%
☐ 95% ☐ 96% ☐ 97%
☐ 98% ☐ 99%

BIOCHIMIE SANG 1 tube (3)

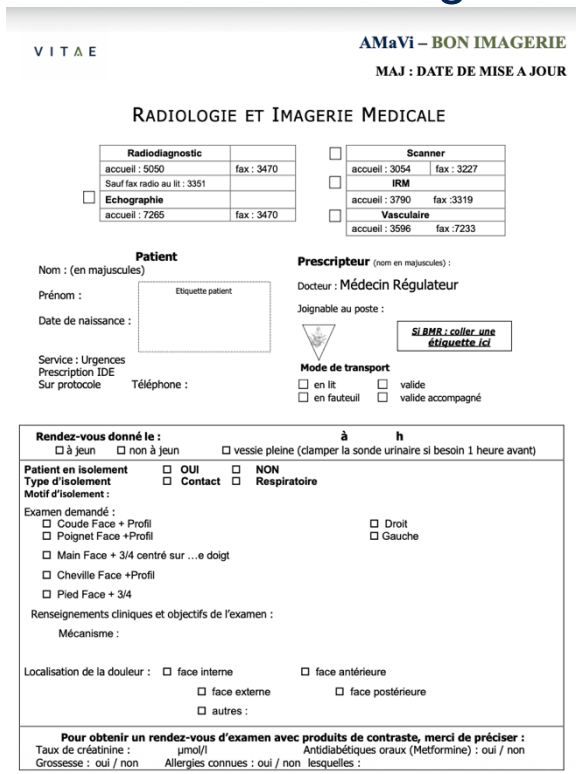
☒ Iono (sodium, potassium, chlore)
☒ Protides
☒ Bicarbonates
☒ Créatinine
☒ Urée
☐ Glycémie

☐ Troponine

☐ HCG

Tube (bouchon pour adulte) 1 = EDTA (violet) 3 = héparine (vert)

Bon de radiologie



VITAE

AMaVi – BON IMAGERIE

MAJ : DATE DE MISE A JOUR

RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE

Radiodiagnostic	
accueil : 5050	fax : 3470
Sauf fax radio au lit : 3351	
Echographie	
accueil : 7265	fax : 3470

Scanner	
accueil : 3054	fax : 3227
IRM	
accueil : 3790	fax :3319
Vasculaire	
accueil : 3596	fax :7233

Patient

Nom : (en majuscules)

Prénom :

Date de naissance :

Etiquette patient

Service : Urgences
Prescription IDE
Sur protocole Téléphone :

Prescripteur (nom en majuscules) :

Docteur : Médecin Régulateur

Joignable au poste :

Si BMR : coller une étiquette ici

Mode de transport

☐ en lit ☐ valide
☐ en fauteuil ☐ valide accompagné

Rendez-vous donné le : **à** **h**
☐ à jeun ☐ non à jeun ☐ vessie pleine (clamper la sonde urinaire si besoin 1 heure avant)

Patient en isolement ☐ **OUI** ☐ **NON**
Type d'isolement ☐ **Contact** ☐ **Respiratoire**
Motif d'isolement :

Examen demandé :
☐ Coude Face + Profil ☐ Droit
☐ Poignet Face +Profil ☐ Gauche
☐ Main Face + 3/4 centré sur …e doigt
☐ Cheville Face +Profil
☐ Pied Face + 3/4

Renseignements cliniques et objectifs de l'examen :

Mécanisme :

Localisation de la douleur : ☐ face interne ☐ face antérieure
☐ face externe ☐ face postérieure
☐ autres :

Pour obtenir un rendez-vous d'examen avec produits de contraste, merci de préciser :
Taux de créatinine : µmol/l Antidiabétiques oraux (Metformine) : oui / non
Grossesse : oui / non Allergies connues : oui / non lesquelles :

Simulation

Objectif

- Mise en situation réaliste d'une situation sanitaire exceptionnelle
- Appliquer les connaissances (ORSAN, AMaVi, Plan Blanc…)

Consignes

Vous allez être confrontés à une **situation simulée**

Vous devrez :

- analyser la situation
- adapter l'organisation du service
- accueillir et prendre en charge les victimes

→ **Tirage au sort de la situation**

VITAE FORMATION SANTÉ

MERCI

POUR VOTRE ATTENTION

VITAE
FORMATION SANTÉ